

**Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

**МДТ «Донишкадаи таҳсилоти
баъдидипломии кормандони соҳаи
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

**Кафедраи кардиология бо курси
фармакологияи клиникӣ**

Ҷ.Ҳ. НОЗИРЗОДА, А.Р. НАРЗУЛЛАЕВА

**БЕМОРИИ ИШЕМИЯВИИ ДИЛ
СТЕНОКАРДИЯ**

Дастури талимӣ-услубӣ

Душанбе-2025

**Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
МДТ «Донишқадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Кафедраи кардиология бо курси фармакологияи клиникӣ**

Ҷ.Ҳ. НОЗИРЗОДА, А.Р. НАРЗУЛЛАЕВА

**БЕМОРИИ ИШЕМИЯВИИ ДИЛ
СТЕНОКАРДИЯ**

Дастури талимӣ-услубӣ

Душанбе 2025

ББК:54.101Я7 (575.3)



Стенокардия. Нозирзода Қ.Х., Нарзуллаева А.Р. Дастури таълимӣ-услубӣ. Душанбе, 2025. 41 сах.

Бо қарори Шӯрои Ҳамоҳангсозии корҳои илмию таҳқиқотӣ ва таълимию методии МДТ “ДТБКСТ ҚТ” ба ҷоп тавсия шудааст (иқтибос аз суратчаласа №2 аз санаи 15.05.2025 сол).

Тақризгарон:

Раҳимов Зақрия Яҳяевич – профессори фахрии кафедраи кардиология бо курси фармакологияи клиникии МДТ “ДТБКСТ ҚТ”, “Корманди шоистаи Тоҷикистон”, н.и.т.

Одинаев Шухрат Фарҳодович - мудири кафедраи бемориҳои дарунии №1 МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, д.и.т., дотсент.

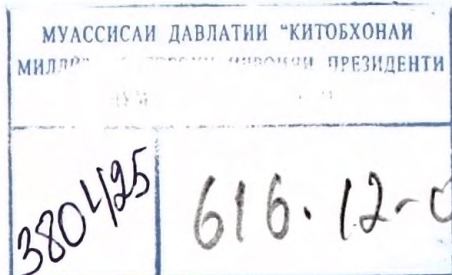
Хуруфчин:

Нозиров Азизҷон Ҷамшедович – табиб-кардиолог, муовини сартабиб оиди табобат ва корҳои ташкилию методии МТТ ҚДММ “Парастор-2014”.

Дастури талимӣ-услубӣ барои табибони бемориҳои дил, терапевтҳо, табибони оилавӣ, ихтисосгирандаҳои аввалия, ординаторону аспирантҳо, инчунин, доираи васен табибони гуногункасб, ки донишу малакаи худро нисбати бемории мазкур васеъ меҳаҳанд қард, пешбинӣ шудааст.

Дастури мазкур хонандаро бо мафҳум, сабабу омилҳо, зинаҳои пайдоиш, таснифоту ташхисот ва пешгирию пешгӯии стенокардия шинос ва ё дониши пештар андӯхтаи ӯро сайкал медиҳад.

Бо забони тоҷикӣ пешкаш гаштани дастур ба доираи васеи хонандагон имкони боз ҳам беҳтар азхуд намудани маводи мазкурро медиҳад.



002268071

МУНДАРИЧА

Руйхати ихтисорот	4
Сарсухан	5
Машғулияти 1. Стенокардия: мафҳум, паҳншавӣ, сабабҳо, омилҳои хавф	6
1.1. Мафҳуми стенокардия	6
1.2. Паҳншавӣ	6
1.3. Сабабҳо	7
1.4. Омилҳои хавфи беморӣ	8
Машғулияти 2. Зинаҳои инкишоф (механизм), таснифот, оризаҳои эҳтимолӣ ва нишонаҳои клинӣ стенокардия	11
2.1. Зинаҳои инкишофи (механизм) стенокардия	11
2.2. Таснифот	12
2.3. Оризаҳои эҳтимолӣ	17
2.4. Нишонаҳои клинӣ беморӣ	17
Машғулияти 3. Ташхисот, ташхисоти тафриқавӣ, табобат, пешгирӣ ва пешгӯии стенокардия	20
3.1. Ташхисоти стенокардия	20
3.2. Ташхисоти тафриқавӣ	24
3.3. Табобат	26
3.4. Пешгирӣ	33
3.5. Пешгӯии беморӣ	34
Тестҳои санҷишӣ	35
Калиди ҷавоб ба тестҳо	39
Замима 1	40
Адабиёт	41

РУЙХАТИ ИХТИСОРОТ

АлАТ - аланинаминотрансфераза
АсАТ - аспартатаминотрансфераза
АИТ - Академияи илмҳои тиб
БДР - бемориҳои дилу рағҳо
БИД - бемории ишемиявии дил
ВЭМ - велоэргометрия
ДДТТ - Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон
ДҚ - диабети қанд
ДТБКСТ - Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустӣ
ИФАТ - ингибиторҳои ферменти ангиотензин-табдилдиҳанда
ЛПЗБ - липопротеидҳои зичиашон баланд
ЛПЗП - липопротеидҳои зичиашон паст
МДТ - Муассисаи давлатии таълимӣ
СБД - сабти барқии дил
СМ - сактаи миокард
ТГ - триглитсеридҳо
ТМР - томографияи магнитно резонансӣ
ТУТ - Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ
ТПЭД - томографияи позитронии эмиссионии дил
ФБШ - фишорбаландии шараёни
ФР - Федератсияи Россия
ФШ - фишори шараёни
Хс - холестерин
ХсУ - холестерини умумӣ
ҚТ - Қумҳурии Тоҷикистон
ШТД - шумораи таппиши дил
ЭхоКГ - эхокардиография
ККА – Колечи кардиологҳои Америка
АКА - Ассотсиатсияи кардиологҳои Америка
ҚКА - Қамъияти кардиологҳои Аврупо
МККА - маҷалаи Колечи кардиологҳои Америка

САРСУХАН

Дар сохтори бемории ишемиявии дил (БИД) стенокардия бо басомадаш чои аввалро ишғол менамояд, аз ин рӯ табибон дар амалия маҳз бо ҳамин шакли БИД бештар вохӯрда, ба мушкилиҳо дар гузоштани ташхису гузаронидани ташхисоти тафриқавии ӯ рӯбарӯ мешаванд. Ин омил онҳоро водор месозад, ки маълумоти бештарро нисбати беморӣ азхуд намуда, дар гузоштани ташхис ба камбудию норасоиҳо роҳ надиханд ва тактикаи дурусти табобатиро пеша намоянд.

Дар дастури мазкур мо ҳаракат намудем, ки ба таври фишурда бошад ҳам, оиди мафҳум, паҳншавӣ, сабабу омилҳои хавф, оризаҳо, зинаҳои пайдоиш, таснифоту ташхисот, ташхисоти тафриқавӣ, инчунин, табобат ва пешгирию пешгӯии стенокардия ба ҳонанда маълумот диҳем ва, дар сурати дониши кофӣ доштаниш, каме бошад ҳам, онро пурра ва мукамал созем.

Дар китоб оиди имкониятҳои усулҳои вазифавӣ ва дастгоҳии ташхис дар гузоштани ташхиси дуруст ҳатто дар мавридҳои, ки бемор нишонаҳои возеҳи бемориро надорад, маълумот пешкаш гардидааст.

Умедворем бо азхуд намудани тартиби муоинаи ин гуна беморон, пайдо кардани маълумоти бештар оиди нишонаҳо, ҷараёнҳои гуногуни ғайриҷашмдошти беморӣ, намудҳои патология, омилу шароитҳои ангежандаи хурӯчи беморӣ, нишондод ба истифодаи усулҳои ташхисӣ сараввал аз дастрасӣ ғайриинвазивӣ, сипас инвазивию серхарочот (ҳангоми нишондод), инчунин, интиҳоби дурусти табобат бо инобати дурнамо, ҳонанда-табиб ба хатогиҳои маъмуле, ки ҳамарӯза бо онҳо дар амалияи табибон вохӯрдан мумкин аст, роҳ намедихад.

Дар охир барои баҳодиҳии сатҳи донишу малакае, ки ҳонанда нисбати патологияи мазкур пайдо намудааст, тестҳои санҷишӣ пешкаш гаштаанд.

МАШҒУЛИЯТИ 1. СТЕНОКАРДИЯ: МАФҲУМ, ПАҲНШАВӢ, САБАБҲО, ОМИЛҲОИ ХАВФ

1.1. Мафҳум

Стенокардия (ТББ 10: I 20; ТББ 11: ВА 40) (лот. *angina pectoris* (қуқи қафаси сина, зикқи дил; юнонӣ «стенос» - танг, зич, сусти ва «кардио - дил») – яке аз шаклҳои аз ҳама беш вохӯрандаи БИД ба ҳисоб рафта, ба ӯ дардҳои хуручкунандаи қафаси синна ва ё эквивалентҳои он дар натиҷаи норасоии коронарӣ, хос мебошад.

Аввалин маротиба соли 1768 аз ҷониби духтури англис Уильям Геберден дар натиҷаи пурсиши 20 бемор падидаҳои клиникӣ хуруҷи стенокардия пешниҳод гашта буд. Ӯ бемориро «ғуқаки қафаси синна» номид, чунки беморон аз тағири кутохмуддати ранги рӯй мисли ғуқ хокӣ-сабзча, ё ки қабуд, инчунин, ҳиссиёти мавҷудияти ғуқи калон дар қафаси синна, ки ба кашидани нафас ҳалал мерасонд, шикоят доштанд. То оғози асри XX ин ном, яъне «ғуқи қафаси синна» нигоҳ дошта шуда буд, вале тибқи ТББ-10 зери тамғаи I 20 «Стенокардия [ғуқи қафаси сина]» номгузорӣ шуд.

1.2. Паҳншавӣ

Ҳамчун падидаи бемории ишемикӣ, стенокардия дар қариб 50% беморон вохӯрда, яке аз шаклҳои аз ҳама беш вохӯрандаи БИД ба ҳисоб меравад. Паҳншавии стенокардия дар байни мардҳо баландтар – 5-20% (дар занҳо – 1-15%) буда, вобаста ба синну сол басомади вохӯрии ӯ меафзояд.

Басомади беморшавӣ аз стенокардия ҳар сол қариб 1%-ро дар мардҳои синну соли 45-65 солаи мамлакатҳои ғарб ташкил дода, дар байни занҳо ин нишондод каме зиёдтар аст. Паҳншавии стенокардия вобаста ба синну сол дар ҳарду ҷинс афзун гашта, синну соли миёнаи беморшавӣ аз ин патология дар мардҳо ба 65, дар занҳо бошад, ба 70 солагӣ рост меояд.

Муайян шудааст, ки басомади стенокардия вобаста ба синну сол яку якбора афзун мегардад: дар занҳо аз 0,1-1% дар синну соли 45-54 сола то 10-15% дар синни 67-74 сола; дар мардҳо аз 2-5% дар синну соли 45-54 сола то 10-20% дар синни 65-74 сола.

Мунтазирӣ аст, ки 10 солаҳои наздик паҳн ва беморшавӣ аз стенокардия, бинобар пиршавии аҳоли (аз он ҷумла, аз ҳисоби усулҳои табобатии умрро дарозкунанда), болоравии эпидемиологияи фарбеҳӣ, инчунин, табобати босамари алоими коронарии шадид, боз ҳам баландтар гардад.

Стенокардия ба сифати ҳаёт таъсири манфӣ расонида, хавфи маъюбиро то 3 маротиба, аз даст додани ҷои корро то 1,5 маротиба, сар задани депрессияро то 4 маротиба афзун мегардонад.

30-40 ҳазор ҳодисаи стенокардия дар миллион одам ба мамлакатҳои ғарб рост омада, 16%-и аҳолии қурраи Замин аз стенокардия азият мекашанд ва 60%-и беморони мубталои ин беморӣ табобати муносиби доругиро намегиранд.

Дар Федератсияи Россия (ФР) ба шаклҳои музмини БИД дар соли 2022 аз нисф зиёди беморон, яъне 63,3% рост омадаанд.

Дар ин сол дар ФР 81,7% фавтҳои, ки аз БИД ба вучуд омадаанд, маҳз ба шаклҳои музмини он рост омадаанд.

Беморшавии умумӣ аз БИД, стенокардия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҶТ), мутобиқи маълумоти Муассисаи давлатии (МД) «Маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббӣ»-и Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҶТ дар соли 2023 181,5 нафарро дар 100 ҳазор аҳоли, беморшавии аввалия бошад, 69,4 нафарро дар 100 ҳазор аҳоли ташкил дод. Дар муқоиса ба соли 2000-ум, ин нишондодҳо, мутобиқи маълумоти Марказ, мутаносибан 1,8 ва 1,3 маротиба ба поён рафтаанд.

Дар 77% беморони аввалин бор ташхисгашта стенокардияи ғайрихос (атипӣ) дарёфт карда мешавад.

Мувофиқи маълумоти МД «Агентии омили назди Президенти ҶТ» дар сохтори фавти аҳолии Тоҷикистон дар давоми якчанд даҳсолаҳои охир бемориҳои дилу раг (БДР) дар ҷои аввал меистанд. Дар солҳои 2022-2023 дар миқёси ҷумҳурӣ аз теъдоди умумии фавтидагон (31 206 нафар) 14 259 нафарро (45,1%) аз БДР ташкил доданд.

Аз бемории ишемикии дил, аз он ҷумла, сактаи миокард (СМ) дар давоми солҳои 2022 ва 2023 мутаносибан 4479 ва 5430 нафар одамон фавтидаанд, ки дар сохтори фавт аз БДР ин нишондод 31,4%-ро дар соли 2022 ташкил дод.

1.3. Сабабҳо

Сабаби асосии стенокардия ҳамчун бемории ишемикии дил тангшавии рагҳои коронарӣ дар натиҷаи *атеросклероз* мебошад. Хуруҷи стенокардия хангоми беш аз 50-70% тангшавии сурохиҳои шараёнҳои коронарӣ ба вучуд меояд. Ҷи қадаре, ки стеноз, яъне тангшавӣ назаррас бошад, ҳамон қадар стенокардия вазнинтар мегузарад. Дарачаи вазнинии

стенокардия, инчунин, аз дарозӣ ва ҷойгиршавии тангшавӣ ва шумораи шараёнҳои иллатбардошта вобастагӣ дорад.

Дар баробари маҳкамшавиҳои атеросклерозӣ, метавонанд равишҳои суддабандӣ (*тромбозболия*) ва тангшавии (*спазм*) рефлектории шараёнҳои коронарӣ сабаби беморӣ бошанд, яъне дар баъзе мавридҳо стенокардия метавонад дар натиҷаи агиоспазм бе мавҷудияти атеросклерози шараёнҳо ба вучуд ояд. Ҳангоми як қатор патологияҳои меъдаю рӯда (чурраи пардадевори байни шикаму қафаси синна, бемории санги талхадон ва ғ.), инчунин, бемориҳои сироятию-барангезӣ, иллатбардорӣ рағҳо дар натиҷаи оташак ва патологияҳои тарбодмонанд (аортит, периартериит, васкулит, эндоартериит) метавонад кардиоспазми рефлекторӣ (дар натиҷаи вайроншавии танзими шараёнҳои коронарии дил аз ҷониби системаи олии асаб) ба вучуд ояд, ки инро *стенокардияи рефлекторӣ* меноманд.

1.4. Омилҳои хавф

Ба пайдоиш, болоравӣ ва падидаҳои стенокардия омилҳои ҳатари тағирпазир (аз байн бурдашаванда) ва тағирнопазир (аз байн бурда нашаванда) таъсир мерасонанд. Ба омилҳои хавфи *тағирнопазири* стенокардия мансубанд: чинс. синну сол ва ирсият.

Вобаста ба чинс, мардҳо бештар хавфи пайдоиши стенокардияро доранд. Ин тамоюл то синни 50-55 солагӣ, яъне то оғози қатъи ҳайз дар организми зан, яъне то он вақте, ки эстрогенҳо — ҳормонҳои ҷинсии зан дил ва рағҳои коронарии ӯро «ҳифз» менамоянд, камтар мушоҳида карда мешавад. Пас аз синни 55-солагӣ стенокардия дар нафарони ҳар ду чинс тахминан бо басомади баробар вомехӯрад. Стенокардия бештар дар ҳеҷу табори наздики маризҳое, ки дорои БИД мебошанд, ва ё сактаи миокардро гузаронидаанд, мушоҳида карда мешавад. Умуман синну сол омилҳои хавф шуморида мешавад агар падидаҳои стенокардия дар мардҳо дар синни то 55 ва дар занҳо то синни 65 солагӣ пайдо шавад.

Ба омилҳои хавфи *тағирпазири* стенокардия инсон имкони тасиррасонӣ ва ё аз байн бурдани онҳоро дорад. Ин омилҳо бо ҳамдигар зич алоқаманд буда, паст сохтани таъсири номатлуби яке, дигареро метавонад аз байн бубарад. Мисол, пастсозии чарбҳо дар ғизои истифодашаванда ба паст гаштани сатҳи холестерин (Хс), вазни бадан ва фишори шараёнӣ (ФШ) оварда мерасонад. Ҳамин тавр, ба катори омилҳои хавфи бартарафшавандаи стенокардия мансубанд: афзунии липидҳо; фарбеҳӣ;

камҳаракатӣ; тамокукашӣ; фишорбаландии шараёнӣ (ФБШ); камхунӣ ва захролудшавӣ (интоксикатсия); диабети қанд (ДҚ): болоравии ғализии хун; стресси руҳӣ-эҳсосӣ ва ғ. Ба ин қатор, инчунин, реаксияҳои иммунӣ, дисфунксияи эндотелӣ, таппиши барзиёди дил, қатъи бармаҳали ҳайз ва қабули контрасептивҳои ҳормониро дар зан, дохил мекунам. Оиди ҳар яке аз ин омилҳо ба таври фишурда маълумот пешниҳод хоҳем кард.

Афзунии липидҳо (ҳиперлипидемия) – дар 96%-и беморони дорои стенокардия афзунии холестерин ва липопротеидҳои дигар (триглитсеридҳо (ТГ), липопротеидҳои зиччиашон паст (ЛПЗП) ва ниҳоят паст), ки таъсири атерогениро дошта, ба замшавии Хс дар шараёнҳои, ки миокардро бо хун таъмин менамоянд оварда мерасонанд, мушоҳида карда мешавад. Болоравии спектри липидҳо дар навбати худ, равиши пайдоиши суддаро дар рағҳо афзун мегардонад. Нишондоди муносиб сатҳи Хс ЛПЗП <100 мг/дл ($<2,5$ ммол/л), сатҳи холестерини умумӣ (ХсУ) <192 мг/дл (5,0 ммол/л) шуморида мешаванд.

Фарбеҳӣ – одатан дар нафароне, ки гизои серкалорияро истифода мебаранд (миқдори барзиёди чарбҳои ҳайвонот, Хс, карбогидратҳо ва ғ.) ва/ва ё камҳаракатиро доранд, ба вучуд меояд, ҳол он ки намудҳои ирсии ин беморӣ низ мавҷуданд. Идеалӣ ҳисобида мешавад агар шохиси вазни бадан аз 18,5 то 24,9 кг/м²-ро ташкил диҳад (Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ - ТУТ, 1997).

Камҳаракатӣ (гиподинамия) – фаъолияти пасти ҷисмонӣ ба сар задани фарбеҳӣ ва вайроншавии мубодилаи липидҳо замина мегузорад. Таъсири ҳамҷояи якчанд омил дар як вақт (афзунии Хс, фарбеҳӣ, камҳаракатӣ ва ғ.) роли ҳалкунандаро дар пайдоиш ва болоравии стенокардия мебозад. Мувофиқи коида тавсияи сарбориҳои аэробӣ то 30-40 дақиқа 3 маротиба дар 1 ҳафта дода мешавад.

Тамокукашӣ – сигоркашӣ дар хун миқдори карбоксигемоглобинро (пайвастаи оксиди карбон бо гемоглобин) афзун намуда (меёри то 3%), ба норасоии оксиген дар ҳуҷайра, дар навбати аввал – дар промиоситҳо, спазми шараёнҳо, болоравии ФШ оварда мерасонад. Ҳангоми мавҷудияти атеросклероз, сигоркашӣ ба пайдоиши бармаҳали стенокардия оварда расонида, ҳавфи сар задани сактаи шадиди миокардро баланд мегардонад. Дар нафарони сигоркаш ҳавфи фавт аз бемориҳои дилу рағ 1,5 маротиба, нисбат ба онҳое, ки онро намекашанд, зиёд аст.

Фишорбаландии шараёнӣ – дар бисёр мавридҳо ҳамрадифи БИД буда, ба болоравии стенокардия мусоидат мекунад. Ҳангоми ФБШ аз ҳисоби баландшавии фишори систоликӣ шиддати миокард баланд гашта, талаботи ӯ ба қабули оксиген афзун мегардад. Ин, дар навбати худ, ба хуруҷи стенокардия ва болоравии он, чӣ тавре дар боло қайд намудем, оварда мерасонад. Нишондоди муносиб – паст кардани фишор аз сатҳи 140/90 мм сут. сим. дар беморони дорои ДҚ ва патологияи гурда бошад, аз сатҳи 130/85 мм сут. сим. поён.

Камхунӣ ва заҳролудшавӣ (интоксикатсия) – ин ҳолатҳо ба поёнравии интиқоли оксиген то ба мушакҳои дил ва сар задани хуруҷи стенокардия чӣ дар заминаи атеросклерозе, ки алақай вучуд дошта бошад ва чӣ бе мавҷудияти он, оварда мерасонад.

Диабети қанд – ҳангоми мавҷудияти диабети қанд БИД, стенокардия то ду маротиба меафзояд. Диабетикҳои дорои собиқаи даҳсолаи беморӣ аз атеросклерози назаррас азиат кашида, дурнамои бадро ҳангоми сар задани стенокардия ва ё СМ доранд. ДҚ намуди 2 хавфи ғавти коронариро то 2 маротиба дар мардҳо ва то 4 маротиба дар занҳо афзун мегардонад.

Ёдовар мешавем, ки бинобар ҷой доштани полинейропатия ва паст, ва ё нест гаштани ҳассосият ба дард, чунин беморон дар бисёр мавридҳо мавҷудияти стенокардиаро дар худ ҳатто пай набурда, мубталои сактаи миокард мегарданд ва беморӣ тасодуфан ҳангоми ташҳиси сабти баркии дил (СБД) ва ё сар задани норасоии гардиши хун дарёфт мегардад.

Баландшавии часпакни нисбии хун – мусоидат мекунад ба суддабандӣ дар мавзеи пайдоиши лавҳаи атеросклерозӣ, хавфи атеротромбози шараёнҳои коронарӣ ва сар задани оризаҳои хатарноки БИД, алалхусус стенокардиаро баланд мебардорад.

Стресси руҳӣ-аҳсосӣ – дил ҳангоми стресс дар шароити сарбории баланд ғаволият намуда, ин ба ангиоспазм, баландшавии ФШ ва бад гаштани таъмини миокард бо оксиген ва моддаҳои ғизоӣ оварда мерасонад. Аз ҳамин ҳисоб стресс омили аз ҳама тавонои хуруҷидиҳандаи стенокардия, СМ, ғавти нобаҳангоми коронарӣ ба ҳисоб меравад.

Якҷояшавии ду ва зиёда омилҳо, ҳатто бо назаррасии миёна, хавфи умумии пайдоиши стенокардиаро баланд мебардорад.

Мавҷудияти омилҳои хавф бояд ҳангоми муайянсозии тактикаи табобатӣ ва пешгирии дуюмини стенокардия ба инобат гирфта шаванд.

МАШҒУЛИЯТИ 2. ЗИНАҲОИ ПАЙДОИШ, ТАСНИФОТ, ОРИЗАҲОИ ЭҲТИМОЛӢ ВА НИШОНАҲОИ СТЕНОКАРДИЯ

2.1. Зинаҳои пайдоиш (патогенез)

Инкишофи стенокардия дар натиҷаи норасоии хунгардиши коронарӣ, ки ба вайроншавии тавозуни байни талаботи кардиомиоситҳо ва воридшавии оксигену қаноатмандӣ аз он оварда мерасонад, ба вучуд меояд. Вайроншавии перфузияи мушакҳои дил ба ишемияи онҳо оварда расонида, дар натиҷа ҷараёни оксидшавӣ дар миокард вайрон мешавад - замшавии барзиёди метаболитҳои то ба охир оксиднашуда (туршакҳои ширӣ, ангиштӣ, пировиноградӣ, фосфорӣ ва диг.) ба вучуд омада, таносубӣ ионҳо вайрон ва истехсоли аденозинсефосфат кам мегардад. Ин равишҳо, дар мадди аввал ба вайроншавии вазифаи диастолиқӣ, сипас систолиқӣ, ихтилолҳои барқию физиолоҷӣ (тағйиротҳои бандаки «ST» ва дандонаи «T» дар СБД) ва, дар ниҳоят, ба пайдоиши дард оварда мерасонанд. Пайдарпаии тағйиротҳои дар миокард гузаронидаро «шалолани ишемикӣ» меноманд, ки асоси онро вайроншави перфузия ва тағйиротҳои метабализм дар мушакҳои дил ташкил дода, зинаи хотимавии он пайдоиши стенокардия мебошад. Норасоии оксиген, ба хусус, бештар аз ҷониби миокард ҳангоми сарбориҳои эҳсосӣ ва ё ҷисмонӣ ҳис карда мешавад, аз ҳамин сабаб хуруҷи стенокардия беш аз ҳама ҳангоми кори барзиёди дил (фаъолияти ҷисмонӣ, стресс) ба вучуд меояд. Дар фарқият аз сактаи шадиди миокард, ки дар натиҷаи он дар мушакҳои дил тағйиротҳои бебозгашт сар мезананд, ҳангоми стенокардия ноҷурии хунгардиши коронарӣ хосияти бозгаштро дорад. Вале, агар гипоксияи миокард остонаи зиндамонии ўро гузарад, дар ин сурат стенокардия метавонад ба СМ анҷом ёбад.

Стенокардия метавонад, инчунин, ҳангоми ҷой надоштани БИД ва иллатҳои бо монета ва, ҳатто, шараёнҳои коронарии солим ба вучуд ояд. Механизми асосии пайдоиши стенокардия дар чунин ҳолатҳо — ин тағйиротҳои вазифавӣ дар сатҳи микрохунгардиши коронарӣ мебошад. Дар асл чунин ҳолатҳо кам нестанд: мутобиқи маълумотҳои баъзе аз тадқиқотҳои регистрӣ қариб дар 2/3 ҳиссаи беморони аввалинбор ташхисгузошта монетаи назарраси коронарӣ мавҷуд нест, ки ин аниқсоии механизмҳое, ки стенокардияро ба вучуд овардаанд, муҳим мегардонад.

2.2. Таснифот

Тибки таснифоти ТУТ (с.1979) ва Маркази умумииттифоқии кардиологии АИТ-и собиқ Иттифоқи Советӣ (1989с.), чунин намудҳои стенокардияро фарқ мекунамд:

Стенокардияи шиддат – дар шакли хуручи дардҳои даргузари паситушӣ падидор гашта, дар натиҷаи сарбориҳои эҳсосию ҷисмонӣ, ки талаботҳои метаболикии миокардро баланд мегардонанд (дилзанӣ, баландшавии ФШ), ба вучуд меояд. Одатан дардҳо дар оромӣ ва ё пас аз қабули зеризабонии нитроглицерин аз байн бурда мешаванд.

Стенокардияи шиддат дарбар мегирад:

Стенокардияи устувори шиддатро – давомнокиаш аз 1 моҳ зиёд. Стенокардияи шиддат устувор шуморида мешавад, агар нишонаҳои беморӣ дар давоми ду моҳ бетағир монанд. Бо дарназардошти қобилияти бардошти сарбориҳои ҷисмонӣ, стенокардияи устувор ба чунин синфҳои вазифавӣ ҷудо карда мешавад:

- Синфи вазифавии I – бардошти хуби сарбориҳои ҷисмонии муқаррарӣ (маъмулӣ); хуручи стенокардия дар натиҷаи сарбориҳои барзиёд, бардавом ва пуршиддат.
- Синфи вазифавии II – каме маҳдудшавии фаъолияти ҷисмонии муқаррарӣ; барангезиши пайдоиши хуруҷҳои стенокардия ҳангоми роҳгардӣ дар ҷойи ҳамвор, дар масофаи 500 метр ва ё зиёда аз он, баромадан ба зинаҳои беш аз 1 ошёна. Ба сар задани хуруҷҳои стенокардия ҳавои хунук, шамол, ба эҳсосот дода шудан, соатҳои аввали бедоршавӣ аз хоб ва ғ. сабаб шуда метавонанд.
- Синфи вазифавии III – маҳдудияти бешаки фаъолияти муқаррарии ҷисмонӣ; пайдоиши хуруҷҳои стенокардия ҳангоми суръати муқаррарии роҳгардӣ дар ҷойи ҳамвор дар масофаи 100-200 метр, баромадан ба зинаҳои ошёнаи 1-ум.
- Синфи вазифавии IV – хуруҷҳои стенокардия ҳангоми сарбориҳои ночизи ҷисмонӣ, роҳгарди дар масофаи то 100 метр, дар байни хоб ва оромӣ.

Ба ғайр аз таснифоти мавҷуд буда дар амалия чунин шаклҳои клиникии стенокардияи устуворро вохӯрдан мумкин аст.

- *Стенокардияи бармаҳали субҳ* (вақти сар задани хуруҷ соатҳои 6-11; механизм: ғаёлгардии системаи асаби соматикӣ бо афзуншавии шумораи таппиши дил (ШТД) ва ФШ).
- *Стенокардияи тиллаві (оғозӣ, стартӣ)* (механизм: афзуншавии талаботи миокард ба оксиген бе пешакӣ ҳамроҳшавии рағҳои гаравӣ (коллатералӣ).
- *Стенокардияи пас аз қабули хӯрок* (механизм: тақсимшавии хун ба узвҳои ҳозима ва «бехунгардонии» дил, ба боло бардошташавии пардадевори байни шикаму қафаси синна бо қисман тобхӯрии дил, ода-тан уфуқишавӣ).
- *Стенокардияи ҳолати хобидан (decubitus)* (механизм: афзунгардии бозгашти варидӣ ва баландшавии пешсарборӣ ба дил бо афзуншавии талабот ба оксиген).
- *Стенокардияи «хунукӣ»* (механизм: тангшавии шараёнҳои мавзеъӣ, афзуншавии вазифаи насосии дил/баландшавии пассарборӣ).
- *Стенокардияи «стрессӣ»* (пас аз хоббинҳои изтиробовар) (механизм: ғаёлгардии системаи асаби эҳсосӣ (симпатикӣ) бо афзуншавии ШТД ва ФШ).
- *Стенокардияи «тамоқуӣ» (tobacco-angina)* (механизм: ғаёлгардии системаи симпатикии асаб бо афзуншавии ШТД ва ФШ, тангшавии рағҳо, афзуншавии ҷамъшавии тромбоситҳо).
- *Стенокардияи «нафаси дуҷум»*, ҳангоми ин шакли стенокардия беморон хуруҷи стенокардияро пас аз лаҳзае паси сар намуда, сарбориро давом медиҳанд (механизм: дар мавзеи ишемия моддаҳои ҳосил мешаванд, ки қобилияти зиёд кардани хуншории коронариро доранд).
- *Нафастангии хуруҷмонанд* (хусусан дар нафарони калонсол ва ё беморони ДҚ) – ҳангоми роҳгардӣ ва ё ҳангоми хобкуни нафастангӣ (дамқӯтоҳӣ), ҳамчун падидаи стенокардия пайдо мешавад (механизм: пастшавии ҳассосияти ресепторҳои, ки ба ҳиссиёти дарди ангинозӣ ҷавобгӯй ҳастанд).
- *Стенокардияи «статикӣ»* вобаста аст ба сарбории яку яқбораи статикӣ (мисол, ҳамшавӣ ҳангоми пушидани пойафзол) (механизм: болоравии пардадевори байни шикаму қафаси синна, тоб хӯрдани дил,

баландшавии фишори даруни қафаси синна, афзуншавии бозгашти варидии хун ва пешсарборӣ ба дил).

Стенокардияи ноустуворо – ин ишемияи шадиди миокард буда, давомнокиаш барои ба вучуд омадани некрози миокард басанда нест. Одатан дар СБД болоравии ST ва дар хун маркёрҳои иллатбардории миокард мавҷуд нестанд (СБД хангоми набудани хуруҷ меёрифт).

Чунин вариантҳои стенокардияи ноустуворо фарқ мекунам (Ҷамъияти кардиологҳои Америка (ҶКА), 2006; Коллеҷи кардиологҳои Америка (ККА)/Ассотсиатсияи кардиологҳои Америка (АКА), 2007):

- стенокардияи оромӣ ва тулонӣ, одатан то 20 дақиқа;
- стенокардияи вазнини аввалинбор пайдошуда (~ III-IV СВ);
- тадриҷаи афзуншавии вазнинӣ ва шиддатнокии стенокардияе, ки пештар вучуд дошт, маҳдудгардии сарбориҳои муқаррарӣ.

Дар амалия бештар таснифоти клиникӣ стенокардияи ноустуворо истифода мебаранд (ҷадвали 1). Ин таснифот дар баҳодиҳии хавфи сарзадани СМ тибқи нишонаҳо ва сабабҳои хуруҷи дард асос ёфтааст.

Ҷадвали 1. Таснифоти стенокардияи ноустувор
(C.W. Hamm, E.B. Braunwald, 2000).

	А. Бо иштироки омилҳои берун аз дилӣ (экстракардиалӣ), ки ишемияи миокардро афзун мебаронанд, ба вучуд меояд. Стенокардияи ноустувори дуҷумин	В. Бе иштироки омилҳои берун аз дилӣ ба вучуд меояд. Стенокардияи ноустувори аввалия	С. Дар давоми 2 ҳафтаи пас аз СМ ба вучуд меояд. Стенокардияи ноустувори пас аз сактавӣ
I – Пайдоиши аввалин стенокардияи вазнин, стенокардияи болорав; бе стенокардияи оромӣ	I А	I В	I С
II – Стенокардияи оромӣ дар давоми як моҳи охир, вале на 48 соати охир (стенокардияи оромӣ, зершадид)	II А	II В	II С

III – Стенокардияи оромӣ, дар давоми 48 соати охир, стенокардияи оромӣ, шадид)	III А	III В III В – тропонин - III В – тропонин +	III С
--	-------	---	-------

Стенокардияи аввалинбор пайдошуда, болорав, стенокардияи оромие, ки дар давоми 7 рӯзи охир пайдо шудааст, аз он ҷумла, аз стенокардияи шиддат ба вучуд омада, стенокардияи бармаҳали пас аз сактавӣ ва ё пас аз ҷарроҳӣ, инчунин, як қатор вариантҳои стенокардияи стихиявиро зери мафҳуми «Стенокардияи ноустувор» муттаҳид менамоянд.

Стенокардияи аввалинбор пайдошуда – ин стенокардияи шиддатест, ки дар давоми то 2 моҳи охир пайдо шуда, вазнинии на кам аз III-юм синфи вазифавиро – тибқи таснифоти Ҷамъияти дилу рағии Канада дорад. Ҷараёни пешгуишавандаро дошта, метавонад ба боло равад, ба ориза – СМ гузарад ва ҳатто ба ғавти нобаҳангом оварда расонад. Инчунин, метавонад ба стенокардияи устувор гузарад ва дар аксар ҳолатҳо регресси стенози рағҳои коронарӣ ва нестшавии падидаҳои клиникӣ беморӣ ба мушоҳида мерасад, ки дар заминаи ин ташаккули шабакаҳои ғаравӣ ва нестшавии реаксияҳои тангшавӣ меҳобанд.

Стенокардияи болорав (прогрессивӣ) – афзунгардии вазнинӣ, давомнокӣ ва басомади хуруҷҳо дар бемор дар ҷавоб ба сарбориҳои муқаррарӣ, пайдошавии минтақаҳои нави ҷойгиршавӣ ва интишори нишонаҳоро дорад.

Стенокардияи бармаҳали пас аз сактавӣ, ва ё пас аз ҷарроҳӣ – стенокардияи шиддат ва ё оромӣ дар давоми 7 рӯзи охир, аз он ҷумла, стенокардияе, ки аз намуди шиддати он ба вучуд омадааст, инчунин, стенокардияи рӯзҳои аввали пас аз гузаронидани СМ, хусусан баъди табобати тромболитикӣ бомуваффақият дар беморони дорои СМ бо болоравии ST. Ин намуди стенокардия хатари сар задани СМ-ро дошта, талаби ҳарчи тезтар гузаронидани коронарографияро барои ҳалли масъалаи гузаронидани ҷарроҳии рағкушӣ, дорад.

Стенокардияи стихиявиро (махсус, вазоспастикӣ, вариантӣ, Принсметал) – ба ин намуди стенокардия лаҳзаҳои тангшавиҳои (спазм) мавзиеи шараёнҳои коронарӣ бе мавҷудияти иллатҳои атеросклерозии возеҳ хос аст. Хуруҷҳои стенокардия танҳо дар оромӣ, шабонгоҳ пас аз

1-3 соати хобравӣ ва ё субҳ бармаҳал пайдо мешаванд. Стенокардияи стихиявие, ки ба баландшавии бандаки «СТ» анҷом меёбад, стенокардияи вариантӣ ва ё Принсметал номида мешавад.

Сабаби ишемия – пастшавии даргузари дастрасии оксиген, на баландшавии талаботи миокард ба $\dot{V}$ аз ҳисоби сарборӣ, мебошад. Дар аксар беморони дорои стенокардияи Принсметал дар давоми 2 моҳи наздик СМ сар мезанад. Бо мурури вақт стенокардияи стихиявӣ метавонад ба стенокардияи устувор гузарад. Ба стенокардияи Принсметал дардҳои саҳт ва бардавоме, ки дар як вақти шабонарӯз пайдо мешаванд, инчунин, фоидапазирии кам аз нитроглитсерин ва β -адреномуҳосирагарҳо, бештар болоравии бандаки ST (на поёнравӣ) ва ё тағиротҳои дигари реполяризации дар СБД ҳангоми хуруҷ, ҳос мебошанд. Антагонистҳои калтсий метавонанд дардро пешгирӣ ва аз байн бубаранд.

Ишемияи бедарди миокард – ин лаҳзаҳои ба ишемия ҳоси депрессияи бандаки ST ҳангоми монитормониторгузаронии холтерӣ ва ё санҷишҳои сарборӣ дар заминаи атеросклерози рағҳои дил, бе мавҷудияти дард ва ё дигар ноформалиҳои субъективӣ мебошад.

J.E. Deanleild бо ҳаммуалифон ба лаҳзаҳои поёнравии (депрессияи) ST дар беморони дорои БИД диққат доданд. Ин депрессияҳо ишемияи бедарди “гунг”-и миокард номида шуданд. Имрӯз тасдиқ гаштааст, ки ин шакли стенокардия аз ҷиҳати пешгӯии оқибатҳои нохушро дошта, дар бисёр мавридҳо ба табobati ҷарроҳӣ ниёз дорад.

Аз ҷониби Донишқадаи миллии тандурустӣ ишемияи “гунг”-ро стенокардияи ҳос мешуморанд агар формулаи $1x1x1$ риоя гардад, ки иборат аст аз: 1) поёнравии ST то 1 мм ва зиёда аз он, ки дар фосилаи 60-80 мс аз нуқтаи j ҳисоби карда мешавад; 2) тулкашии ин поёнравӣ то 1 дақиқа; 3) кафомонии тулкашӣ аз дигар лаҳзаҳо то 1 дақиқа.

Чунин намудҳои ишемияи бедарди миокардро фарқ мекунанд:

- ишемияи бедарди миокард бе падидаҳои клиникалии БИД (намуди I);
- ишемияи бедарди миокард дар бемороне, ки СМ-ро гузаронидаанд (намуди II);
- ишемияи бедарди миокард, ки дар беморони дорои стенокардия дарёфт гаштааст (намуди III).

Ишемияи бедарди намуди I-умро ҳамчун нишонаи ягона ба мавҷудияти БИД ва II-ро ҳамчун нишонаи пешгунии ҷиддӣ ва зарурат ба гузаро-

нидани коронарография (ҳангоми мавҷуд набудани стенокардияи пас аз сактавӣ), дар ташҳис мебароранд, яъне дарч менамоянд. Ишемия бедарди намуди III-ро бошад, ҳангоми ташҳиснависӣ метавон дар ташҳис ворид намуд ва ё дар ҳуччатҳои тиббӣ махсус дар борааш таъкид намуд.

Сабаби баъзе аз лаҳзаҳои ишемияи бедард ва баъзеашон, ки бо нишона мегузаранд, то ба охир маълум нест. Бинобар он, ки ишемияи бедард бештар дар беморони дорои ДҚ мушоҳида мешавад, метавон таҳмин намуд, ки ин ба вайроншавии ҳассосият ба дард алоқаманд буда, дар натиҷаи сар задани нейропатияи мавзёӣ ба вучуд ояд.

Стенокардияи микрорагӣ (микроваскулярӣ, алоими X) – ин бемории дорои нишонаҳои хоси стенокардия, бе мавҷудияти нишонаҳои иллатбардорӣ назарраси тангкунанда дар шараёнҳои коронарӣ ҳангоми ангиографияи коронарӣ, мебошад. Патогенези ишемия, дар чунин ҳолатҳо, метавонад бо захираи нокифояи рагвасеъкунандаи шараёнҳои хурди коронарӣ, яъне васеъшавии нокифояи ин рагҳо дар давраҳои афзуншавии талаботи миокард ба оксиген, алоқаманд бошад. Ҳисоёти дард ҳангоми ин алоим як қатор хусусиятҳоро дорад: якум – хуруҷҳои ангинозӣ бештар ҳангоми сарбориҳо пайдо мешаванд, гарчанде дар оромӣ низ метавонанд пайдо шаванд; дуюм – пас аз қатъи сарборӣ ҳангоми ин шакл, нисбат ба иллатгириҳои бо монанди шараёнҳои коронарӣ, дардҳо тулонӣ давом карда, пас аз қабули нитроглитсерин дертар бартараф мегарданд; сеюм – алоими дарди қафаси синна ҳангоми ин шакл вазнинтар буда, қобилияти ба тариқи назаррас халалдоркунии на танҳо сифати зиндагии бемор, балки қобилияти меҳнати ӯро низ дорад.

2.3. Оризаҳои эҳтимолӣ

Дар беморони дорои стенокардияи устувор ҳамеша ҳавфи ноустуворшавӣ бо сар задани оризаҳои гуногун вучуд дорад: сактаи шадиди миокард, вайроншавии назми дил ва гузарониш, норасоии музмин ва шадиди дил (диққи дил, обварамии шӯшҳо, садма), инчунин, кардиосклероз.

2.4. Нишонаҳои клиникӣ стенокардия

Падидаҳои клиникӣ стенокардия, чи тавре болотар қайд намудем, аввалин маротиба аз ҷониби духтури англис Уилям Геберден то ҳамоно дараҷа аниқ навишта шуда буд, ки имрӯз ба ин навиштаҷот ягон чиз илова кардан номумкин аст. Ҳоло беҳтар мешавад агар маҳакҳои сте-

нокардия, ки аз чониби АКА тавсия шудааст ва тибқи он стенокардия ҳангоми пурсиши беморон муайян карда мешавад, истифода барем. Мувофиқи ин маҳакҳо, стенокардияи шиддати хосро метавон ҳангоми мавҷудияти се нишона муқаррар намуд:

- ♦ дард (ё ки ҳисси нофорамӣ) дар паси тӯш;
- ♦ алокаи ин дард бо сарборихои ҷисмонӣ ва ё эҳсосӣ;
- ♦ бартарафшавии дардҳо пас аз қатъи сарборӣ ва ё қабули нитроглитсерин.

Мавҷудияти ду аз се нишонаҳои номбаршуда ба стенокардияи ғайрихос (эҳтимолӣ), мавҷудияти танҳо як нишона бошад, асос барои гузоштани таъхиси стенокардия шуда наметавонад. Азбаски беморон на ҳама вақт ҳиссиётҳои худро фаҳмонида метавонанд, табибон ба гузоштани таъхиси дуруст дар асоси шикоятҳои онҳо танқисӣ мекашанд.

Нишонаҳои стенокардияи хос – ин *шикоят* ба *дардҳои* паситишӣ, баъзан чаптар аз туш (дар мавзеи дил). Ҳиссиёти дард метавонад тангкунанда, зеркунанда, сузишнок, баъзан буранда, кашанда, суроҳкунанда ва ғ., бошад. Вазнинии дард метавонад аз сатҳи тоқатпазир то назаррас бошад, ки беморро мачбур созад ба дод задан, ҳисси тарс аз ғавти наздикомада. Ҳангоми хуруҷи стенокардия беморон камгапанд ва ҷойгиршавии дардро бо муште, ки ба туш зер кара мешавад, нишон медиҳанд (нишонаи С. Левин).

Дардҳо бо бартарӣ ба даст ва китфи чап, ҷоғи поён, зери белаки чап, ба мавзеи эпигастрӣ *интишор* меёбанд; дар ҳолатҳои ғайримукаррарӣ – ба қисмати рост тан, пойҳо. Интишори дардҳо ҳангоми стенокардия вобастагӣ дорад аз паҳншавии онҳо аз дил то ба VII-ум ва I-V-ум бандакҳои (сегмент) синнагии ҳарромағз, сипас бо асабҳои марказдав ба минтақаҳои паҳншавии асабҳои, ки аз сегментҳои номбарашта сарчашма мегиранд.

Дардҳо ҳангоми стенокардия бештар дар лаҳзаҳои роҳгардӣ, баромадан ба зинаҳо, зурзанӣ, шабонгоҳ пайдо мешаванд.

Давомнокии хуруҷҳои дард 15-20 дақиқа. Омилҳои, ки хуруҷи стенокардияро *сабук мегардонанд*: қабули нитроглитсерин, ҳолати нишаст ва ё рост истодан мебошанд.

Дар бемороне, ки стенокардияи намуди ғайрихосро (атипикӣ) доранд нишонаҳои беморӣ дар мард ва занҳо ҷунин бесомадро дорад:

- зеркуниҳо дар қафаси синна – 67% дар мардҳо ва 66% - дар занҳо;
- дард дар қафаси синна – 55% дар мардҳо ва 61% - дар занҳо;
- нафаскашии қинд – 47% дар мардҳо ва 55% – дар занҳо;
- мондашавии барзиёд – 53% дар мардҳо ва 58% - дар занҳо;
- стресс, изтироб/депрессия – 29% дар мардҳо ва 34% - дар занҳо.

Дар беморони дорои стенокардияи ноустувор шикоятҳои асосӣ дар ҳамаи ҳоси ангинозӣ пасиштушӣ тулқашандаи интишорёрбанда ва ё бешор, ки аз қабули нитроглитсерин намегузаранд, мебошанд.

Дар фарқият аз стенокардияи устувор, ҳангоми стенокардияи ноустувор басомад, афзунгардӣ, вазниншавӣ (нофорамӣ дар қафаси синна) дар натиҷаи сарбории кам ва ё оромӣ пайдо мешаванд.

Ҳамаи беҳи (эквивалентӣ) хуручи стенокардия метавонанд чунин нишонаҳои даргузар, ба мисли: нафастангӣ, вайроншавии назм, ҳолатҳои беҳушшавӣ бошанд.

Нишонаҳои *объективӣ* стенокардияи хос вучуд надоранд, вале ҳангоми хуруҷ ранги бемор паррида, рӯяш шакли азияткашидаро мегирад, андомҳои боло хушк ва қарахт мешаванд. Дар бемор нишонаҳои атеросклерозии иллатбардорӣ шоҳрағ ва рағҳои мавзеъиро дидан мумкин аст – ксантомаҳо, ксентелазмҳо, ҳалқа дар қарни. Сараввал набз афзун, сипас паст гашта, метавонад номураттабии қори дил, бештар экстрасистолияҳо ба қайд гирифта шаванд. Ҳангоми аускултатсия дар рағҳои мавзей шувос шунидан мумкин аст. Майл намудани зарбаи қуллавӣ, сарҳадҳои дил ба чап, каме пастшавии зарбаи I-ум, баландшавии зарбаи II-ро аз ростӣ тӯш дар II-юм байниқабурға шунидан мумкин аст. Бештар афзуншавии фишор, баъзан (ҳангоми стенокардияи ноустувор) пастшавии онро мушоҳида қардан мумкин аст.

Хуруҷҳои бардавоми стенокардия метавонанд ба СМ табдил ёбанд, ки ӯ нишонаҳои ба худ ҳоси объективиро дорад.

МАШҒУЛИЯТИ 3. ТАШХИСОТ, ТАШХИСОТИ ТАФРИҚАВӢ, ТАБОБАТ, ПЕШГИРӢ ВА ПЕШГӢИИ СТЕНОКАРДИЯ

3.1. Ташхисот

Табибон ба гузоштани ташхиси дурусти стенокардия дар асоси ши-
коятҳо дар баъзе мавридҳо танқисӣ мекашанд. Аз ҷамин рӯ, истифодаи
пурсишномаҳои стандартӣ, ки дар байни онҳо аз ҳама маъмулаш пур-
сишномаи Rose (замимаи I) ба ҳисоб меравад, айни мудаост. Ин пурсиш-
нома имкон медиҳад, ки яғон аз саволи муҳиме, ки барои гузоштани
ташхиси дурусти стенокардия зарур бошанд, дар он ба назар нагирифта
шуда бошанд, аз ин ҷо – эҳтимолияти гузоштани ташхиси аниқ ҳангоми
истифодаи ин пурсишнома бениҳоят баланд аст (ҳассосият 91,4%). Пур-
сишномаи Rose дар баробари стенокардия, метавонад барои дарёфти
сактаи гузаронида, лангидани бо фосила ёрӣ расонида, имкони ҷудо
намудани нафарони конкретиро бо пешгӯии номатлуб ва хавфи баланд,
бидиҳад.

Барои гузоштани ташхиси стенокардия пеш аз ҳама *шикоятҳои бе-
морро* бояд ба инобат гирифт: аз он ҷумла ҳосият, ҷойгиршавӣ, интишор
ва давомнокии дардҳо, шартӣ пайдоиши онҳо ва омилҳои аз байн бур-
дани онҳоро (нигаред ба боло – нишонаҳои клиникӣ).

Анамнези бо пурраги ҷамъгашта, дар навбати дуҷум, дар бисёр ҳо-
латҳо дар гузоштани ташхиси дуруст роли бениҳоят калонро мебозад, аз
он ҷумла, мавҷудияти омилҳои хавфи БИД, таърихи ирсӣ ва гинекологӣ
дар занҳо (муҳлати аз ҳайз мондан), ҳодисаҳои, ки пеш аз оғози дард
бемор аз сар гузаронидааст, бемориҳои ҳамрадиқ ва ғ. Дар ниҳоят исти-
фодаи *усулҳои иловагӣ* муносибу дастраси ташхис дар аниқсозии таш-
хис роли калидино мебозанд.

Ташхисоти лабораторӣ тадқиқотҳои: ХсУ, АсАТ ва АлАТ, липо-
протеидҳои зиччиашон баланд (ЛПЗБ) ва ЛПЗП, ТГ, лактатдегидроге-
наза, креатинкиназа, глюкоза, сафедаи СР, коагулограмма ва электролит-
ҳои хунро дарбар мегирад.

Аҳамияти ҳоси ташхисиро муайянсозии маркёрҳои тропонинҳои I ва
Т-и кардиалӣ доранд, ки аз иллатбардории миокард шаҳодат медиҳанд.
Дарёфти ин сафедаҳои миокардиалӣ аз микросакта ва ё сактаи калонман-
баъ шаҳодат дода, имкони пешгирии стенокардиин пас аз сактавино
медиҳанд.

Сабти барқии дил – агар ҳангоми хуручи баланди стенокардия гузаронида шавад, поёнравии фосилаи ST, мавҷудияти дандонаи манфии T-ро дар барришҳои синнагӣ, вайроншавии гузарониши назро нишон медиҳад.

СБД – монитorkунонии шабонарузӣ имкони ба қайд гирифтани тағиротҳои ишемикӣ, ва ё чой надоштани онҳоро дар СБД ҳангоми хуруҷҳои стенокардия, инчунин ШТД, вайроншавии назро медиҳад. Афзуншавии ШТД пеш аз хуруҷ, имкони фикррониро нисбати стенокардияи шиддат, ШТД-и меъёрӣ бошад – нисбати стенокардияи стихиявӣ, медиҳанд.

СБД бо санҷишҳои сарборӣ – усули аз ҳама иттилоотӣ барои дарёфти нишонаҳои БИД ба ҳисоб меравад.

Пеш аз гузаронидани санҷишҳо бо сарборӣ барои аниқсозии БИД ва хулосабарорӣ аз натиҷаҳои ӯ мебояд ба инобат гирифт эҳтимолияти пеш аз санҷишии (априории) бемориро дар бемор (ҷадвали 2).

Ҷадвали 2. Эҳтимолияти пеш аз тестии БИД, ки дар вобастагӣ аз синну сол, ҷинс ва нишонаҳои клиникӣ ҳисобӣ гаштааст.

Синну сол	Ҷинс	Стенокардияи хос ва ё муайян	Стенокардияи ғайрихос ва ё эҳтимолӣ	Дарди ғайридилӣ дар қафаси синна	Набудани нишонаҳо
30-39	Мардҳо	Мобайнӣ	Мобайнӣ	Паст	Бениҳоят паст
	Занҳо	Мобайнӣ	Бениҳоят паст	Бениҳоят паст	Бениҳоят паст
40-49	Мардҳо	Баланд	Мобайнӣ	Мобайнӣ	Паст
	Занҳо	Мобайнӣ	Паст	Бениҳоят паст	Бениҳоят паст
50-59	Мардҳо	Баланд	Мобайнӣ	Мобайнӣ	Паст
	Занҳо	Мобайнӣ	Мобайнӣ	Паст	Бениҳоят паст
60-69	Мардҳо	Баланд	Мобайнӣ	Мобайнӣ	Паст
	Занҳо	Баланд	Мобайнӣ	Мобайнӣ	Паст

Эзоҳ: эҳтимолияти баланд – >90%; эҳтимолияти мобайнӣ – 10-90%; эҳтимолияти паст – <10%; эҳтимолияти бениҳоят паст – <5%.

Ҳангоми гузаронидани тестҳо бо сарбориҳои ҷисмонии воявӣ тобовари беморро ба сарбориҳои ҷисмонӣ, инчунин, нишонаҳои клиникӣ ва СБД-ии ишемияи миокардро бо мақсади ташхисоти БИД, дарёфт

намудан мумкин аст. Ба тестҳо бо сарбории ҷисмонӣ дохил меша-ванд: велоэргометрия (ВЭМ), тредмил-тест ва ғ.

ВЭМ тестест, ки нишон медиҳад кадом сарбориҳои максималиро бе хавфи пайдоиши ишемия бемор метавонад бардошт намояд. Фармоиши сарборӣ тавассути велотренажёр то расидан ба ШТД-и субмаксималӣ бо қайди СБД дода мешавад. Ҳангоми тести манфӣ ШТД-и субмаксимали дар давоми 10-12 дақиқа ба даст омада, падидаҳои клиникӣ ва ишемикӣ дар СБД дида намешаванд. Тест мусбӣ шуморида мешавад агар ҳангоми сарборӣ хуруҷи стенокардия ва ё майли бандаки «ST» то 1 мм ва зиёда аз он мушоҳида карда шавад.

Тредмил-тест – нисбат ба велоэргометрия бартарият ва норасоӣҳои худро дорад. Бартарияш пеш аз ҳама дар он аст, ки сарборӣ ҳангоми гузаронидани ин усул хусусияти бештари физиолоҷиро дошта, беморон ўро ҳамчун сарбории ҳама-рӯза қабул менамоянд. Ба ғайр аз ин, ҳангоми истифодаи протоколи стандартӣ Bruce эҳтимол дорад иҷрои сарбориҳои баландтар нисбат ба велоэргометрия ва каме тезтар расиданро ба натиҷаи дилҳо.

Ҷадвали 3. Хислатдихии муқоисавии баҳои вазъи вазифавӣ ҳангоми истифодаи велоэргометр ва тредмил.

Хислатҳо	Велоэргометр	Тредмил
Ҷанкунии тавоноии сарборӣ	-	+
Мамониат ва артефактҳо	↓	↑
Бехатарии тадқиқот	↑	↓
Дарачаи машқкунии мушакҳои пой	↓	↑
Душвориҳо дар беморони дорон фарбеҳӣ	↓	↑
Физиолоҷӣ будани тадқиқот	↓	↑
Нафароне, ки бештар ба гузаронидани таҳқиқот рост меоянд	беморон	нафарони солим

Дарёфти стенокардия, инчунин, бо роҳи ангезиши ишемияи даргузари назоратшавандаи миокард имкон дорад – тавассути тестҳои вазифавӣ (ангезиши тавассутисурхноии даҳлезҳо), фармаколоҷӣ (бо истифодаи изопротенолол, дипиридамола).

Ҳангоми имкон надоштани иҷрои сарбориҳои ҷисмонӣ, тестҳоро бо дипиридамола, эргометрин ва добутамин истифода мебаранд.

Тести аз ҳама иттилоотӣ – ин тести *доруғӣ* бо добутамин ба ҳисоб меравад. Тест бо эргометрин бошад, барои тасдиқи механизми спастикии

норасоии коронарӣ (стенокардияи Принсметал) дар беморони дорои БИД истифода мешавад (дар сурате, ки ангиографияи коронарӣ ягон тағиротро намеёбад).

Нумӯи барқии тавассутисурхноии дил – ин низ усули бениҳоят иттилоотноки ғайриинвазивӣ дар ташхисоти БИД ба ҳисоб рафта, барои омӯзиши ҳислат ва механизмҳои барқию физиолоҳии вайроншавии назми дил, инчунин, барои нест кардани хуруҷҳои дилзаниҳои боломеъдачавӣ истифода мешавад.

Ҳангоми тестгузаронӣ бо сарбориҳои ҳисмонӣ ва фармакологӣ ба инобат гирифтани нишондод ва мамнуъ ба гузаронидани онҳо бениҳоят зарур аст.

Гумроҳии аз ҳама паҳнғашта ҳангоми манфӣ будани натиҷаи тестҳо бо сарборӣ инҳоянд:

- тести манфӣ ба мавҷуд набудани БИД нишон медиҳад (ҳассосияти усул аз 70% зиёд нест, ҳамин тавр аз се як ҳиссаи беморон натиҷаҳои бардурӯғи манфиро доранд);
- тестро ба бемороне, ки алақай БИД-ро доранд мегузаронанд, хусусан, бо мавҷудияти кардиосклерози пас аз сактавӣ (мувофиқи мақсад шуморида мешавад гузаронидани тест танҳо барои муайянсозии пешгӯи ва баҳодиҳии самаранокии табобат);
- тестро ба бемороне мегузаронанд, ки падидаҳои клиникӣ беморию надоранд (арзиши ташхисии тест дар ин тоифаи одамон бисёр паст аст).

ЭхоКГ ҳангоми стенокардия ба тағиротҳои лонавии ишемикӣ ва вайроншавии кашишхуриҳои миокард, қобилияти зиндамонии миокарди ишемияро гузаронида (миокарди “гибернишуда” ва “станнингшуда”) нишон медиҳад.

Синтиграфияи миокард бо мақсади дарёфти перфузияи мушакҳои дил ва дарёфти тағиротҳои манбавӣ дар он, гузаронида мешавад. Маводи радиофаъоли таллий аз ҷониби кардиомиоситҳои зинда фуру бурда мешавад, вале ҳангоми стенокардияе, ки ба кардиосклероз анҷом ёфтааст, минтақаҳои лонавии вайроншавии перфузияи миокард дарёфт карда мешаванд.

Коронарографияи таххисӣ барои баҳодихии ҷойгиршавӣ, дараҷа ва паҳншавии иллати шараёнҳои дил гузаронида мешавад, ки ин имкони интиҳоби усули табобатиро (консервативӣ ва ё ҷарроҳӣ) муайян месозад.

Рентгенографияи қафаси синна (дил, шӯшҳо ва рағҳои хунгард) тасвири дилро дар қафаси синна, ҷойгиршавии ӯ, андозаҳои меъдача ва даҳлезҳо, инчунин, нишонаҳои норасоии дилро метавонад дарёфт намояд. Шуонидихии рентгенӣ бо вояҳои баланд барои ҳаёт, бинобар эҳтимолияти баланди сар задани бемориҳои саратонӣ хатарнок аст, вале ҳангоми тазриқҳои стандартӣ вояи шуогузаронӣ хатари иловагиро ба организм намерасонад.

Томографияи компютерии дил имкон медиҳад дуруштшавӣ ва тангшавии шараёнҳои калонро дарёфт намояд, инчунин, замшавии калтсийро дар деворҳо ҷашмрас намояд, ки ин нишонаи бармаҳали БИД-и эҳтимолӣ ба ҳисоб меравад. Бартарии возеҳи усул – ин ғайриинвазивӣ будани он нисбат ба ангиографияи контрастӣ мебошад.

Дар як қатор ҳолатҳо метавонанд усулҳои боз ҳам чуқур ва серхароҷоти таҳқиқот тавсия шаванд:

Томографияи магнитию резонансии (ТМР) дил – метавонад иллати бофтаҳо ва ё проблемаҳои ба хуншории дил ва рағҳои коронарӣ таалуқ дошта, инчунин, тағиротҳои рағҳои майдаро дарёфт намояд. Усул метавонад ҳангоми ташхисоти иловагии БИД (бахусус БИД-и бе монеа, бенишона) ва иллатҳои микрорағӣ истифода шавад. Мувофиқи қоида ТМР-и дилро барои аниқсозии натиҷаҳои дигар таҳқиқотҳои ҷашмраскунанда, бахусус, рентгени қафаси синна ва ё томографияи компютерӣ, таин мекунад.

Томографияи позитронӣ эмиссионӣ дил (ТПЭД) – имкони баҳодихии хуншориро тавассути рағҳои майдаи коронарӣ ва бофтаҳои дил медиҳад, инчунин, барои ташхиси стенокардияи микрорағӣ (алоими Х) ва дигар патологияҳое, ки ба рағҳои майда алоқамандӣ доранд, истифода шавад.

3.2. Ташхисоти тафриқавӣ

Бисёр муҳим аст фарқкунонии хуруҷҳои стенокардияи шиддат аз дардҳои қафаси синна, ки ҳангоми дигар бемориҳо пайдо мешаванд. Ба бемориҳои асосие, ки бо онҳо стенокардиаро мебояд тафриқа гузаронид, мансубанд: аневризми қабатҷудои шоҳрағ, аксулчараёнӣ дар сурхрӯда,

спазми сурхрӯда, кафидани сурхрӯда, панкреатит, бемории захми рудаю меъда, бемориҳои девори қафаси синна, перикардит, Herpes zoster.

Ҳамчун нишонаи фарккунандаи дардҳои ғайрикоронарӣ метавонанд хизмат намоянд:

- шикояти беморон ба дарди тулонӣ ва беш аз 15-20 дақиқа, ҳатто якчанд соат ва рӯзҳо;
- алоқамандӣ надоштани дардҳо бо сарбориҳои ҷисмонӣ;
- ҳислатдихии дард, аз ҷониби беморон, на хуруҷкунанда ва зеркунанда, балки кунд ва сим-сим (ноланда);
- ҷойгиршавии дард дар мавзеи қуллаи дил ва ё чаптар аз тӯш, интишори ғайриҳоси дардҳо;
- бесамарагӣ аз қабули нитроглитсерин.

Дуруст ҷамъоварӣ гаштани таърихҳои беморӣ ва ҳаёт, мавҷудияти омилҳои хавф, бемориҳои ҳамрадиқ, инчунин, истифодаи усулҳои ташҳисӣ, сар карда аз ғайриинвазивӣ, сипас инвазивӣ (ҳангоми нишондод), барои гузоштани ташҳиси стенокардия роли муҳим мебозанд.

Ба табиби амалия ҳамагӯза ҳалли проблемаи ташҳисоти тафриқавии стенокардияи устувор, стенокардияи ноустувор ва кардиалгия (дардҳои ғайриангиналӣ дар қафаси синна) пеш меоянд. Дар ҳалли масъалаи мазкур таснифоти клиникӣ дард дар қафаси синна ёрӣ хоҳад расонид (ҷадвали 4).

Ҷадвали 4. Таснифоти клиникӣ дард дар қафаси синна (МККА, 1983).

Намуди клиникӣ	Ҳислатнома
Стенокардияи ҳос (типикӣ, исботшуда)	Ҳама нишонаҳо дида мешаванд: 1) нофорами зеркунанда (дарди ангинозӣ) дар қисмати пеши қафаси синна, ё ки дар мавзеи гардан, ҷоғ, китф ва ё дастон; 2) дар натиҷаи сарбории ҷисмонӣ пайдо мешавад; 3) пас аз қабули нитроглитсерин, ё ки истироҳат дар давоми 5 дақиқа мегузарад.
Стенокардияи ғайриҳос (атипикӣ)	Дар бемор аз 2/3 нишонаҳои дар боло номбаршуда дида мешаванд.
Дарди ғайриангиналӣ дар қафаси синна	Дар бемор танҳо яке аз нишонаҳои дар боло номбаршуда дида мешаванд.

3.3. Табобат

Вазифаи мубрами тандурустӣ – таҳияи дурнамои табобати пурса-мари стенокардия ва, дар ин замина, паст сохтани хавфи сар задани оризаҳои асосӣ ва ғавти дилу рағӣ мебошад.

Муолиҷаи стенокардияи устувор якчанд самтхоро дарбар мегирад:

- азбайнбарӣ ва ё пастсозии нишонаҳои бемориро;
- пешгирии пайдоиши стенокардияи ноустуворро;
- афзунгардони бардошти сарбориҳои ҷисмониро;
- беҳсозии пешгӯии беморӣ ва пастсозии хавфи ғавти нобахангомо.

Табобати ғайридоругии стенокардия – риояи принципҳои тарзи ҳаёти солимро дарбар мегирад:

- Дасткашӣ аз тамокукашӣ;
- Сарбориҳои мунтазами ҷисмонӣ 30-40 дақиқа на кам аз 3 маротиба дар давоми ҳафта;
- Пастсозии вазни бадан то сатҳи аз 25 кг/м^2 поён;
- Истифодаи ғизои солим (тибқи тавсияҳои Аврупоӣ оиди ғизо, синфи тавсияи I, сатҳи далелнокии B):
 - истеъмоли $<5\text{г}$ намаки ошӣ;
 - истифодаи бениҳоят ками чарбҳои сершуда ($<10\%$ аз калорияи ғизо);
 - маҳдудсозии максималии трансчарбҳо ($<1\%$ аз калорияи умӯмии ғизо);
 - истеъмоли 500г меваю сабзавот дар як рӯз;
 - истеъмоли 30-45г нахҳои ғизоӣ аз меваю сабзавот ва маводҳои ғалладонагӣ;
 - истеъмоли моҳӣ на кам аз 2 маротиба дар 1 ҳафта, ҳамзамон як моҳияш бояд, ки серравған бошад;
 - маҳдудкунонии истифодаи нушокиҳои спиртдор аз ҳисоби спирти тоза то 20г дар 1 рӯз барои мардҳо ва то 10г – барои занҳо.

Ин одатҳо метавонанд дар оянда хавфи пайдоиши оризаҳо ва ғавти дилу рагиро паст созанд, натиҷаҳои риояи тарзи ҳаёти солимро алақай пас аз 6 моҳ دیدан мумкин аст.

Табобати доругӣ

Тавсияҳои мубраме, ки аз ҷониби ҷамъиятҳои пешрафтаи табибон пешниҳод гаштаанд, гузаронидани табобати зидди ангиналии доругиро (консервативӣ) пеш аз гузаронидани усулҳои ҷарроҳии рағкушӣ медиҳанд.

Табобати нақшавии доругии стенокардия қабули дорухои зидди ангинали (зидди ишемикӣ), яъне пасткунандаҳои талаботи мушакҳои дилро ба оксиген дарбар мегирад: нитратҳои дарозтаъсир (изосорбиди динитрат, нитроқонтин, пентаэритритили тетранитрат ва ғ.), β-адреномуҳосирагарҳо (анаприлин, окспренолол, метопролол, атенолол ва ғ.), молсидомин, муҳосирагарҳои ҷӯйчаҳои калтсий (верапамил, дилтиазем), триметазидин ва ғ.

Нитратҳо ва молсидомин — маводҳои доругии асосие ба шумор мераванд, ки барои аз байн бурдани хуруҷи стенокардия ва пешгирии ӯ истифода мешаванд.

Молсидомин қариб, ки бо механизми зидди ангиналинаш ба нитратҳо монанд аст. Дорухои молсидомин (корватон ва сиднофарм) бо таъсири миёнафосилавии худ (қариб 4-6 соат) фарқ мекунанд ва барои ҳамин барои пешгирии хуруҷҳои стенокардия, яъне ба тариқи нақшавӣ истифода бурда мешаванд.

Барои аз байн бурдани хуруҷи стенокардия одатан шаклҳои кутоҳтаъсири нитроглитсерин ва изосорбиди динитрат истифода бурда мешаванд. Усули паҳнғаштаи аз байн бурдани хуруҷи стенокардия — қабули зеризабонии нитроглитсерин (0,5мг). Бо дарназардошти хавфи яку якбора паст гаштани ФШ тавсияи на зиёда аз 2-3 ҳабби нитроглитсерин бо фосилаи ҳар 5 дақиқа дода мешавад.

Сабуқшавии дардҳо пас аз қабули нитроглитсерин одатан пас аз 1-2 дақиқа, самараи максималӣ бошад, пас аз 5-6 дақиқа ба амал омада, то 10-20 дақиқа давом мекунад. Бартарии қабули зеризабонии дору дар он аст, ки мустақиман ба хунгардиш ворид гашта, тавассути ҷигар намегузарад.

Самараҳои номатлуб аз қабули нитроглитсерин ва дигар нитратҳои дарозтаъсир — дарди набззанандаи сар, ҳиссиёти дамидани сар, шувос дар гӯшҳо, сурхшавии рӯй, дилзанӣ, ки ҳамаи ин ба васеъшавии варид-

ҳои дохили косахонаи сар ва қиндшавии бозгашти хун аз майнаи сар, инчунин, васеъшавии рағҳои музофотӣ (дилзанӣ) вобастагӣ дорад.

Шаклҳои кӯтоҳтаъсири нитратҳоро то 4 маротиба; нитратҳои бо таъсири 3-6 соатро на бештар аз 2 маротиба дар як рӯз (сахару беғох), доруҳои таъсири 6-12 соатро бошад, на зиёда аз 1 маротиба дар як рӯз таъин менамоянд. Ба беморони дорои хуруҷҳои стенокардия дар заминаи сарборихои ҷисмонӣ (стенокардияи шиддати I-II СВ), тавсияи қабули нитратҳои кӯтоҳ ва миёнатаъсирро бевосита пеш аз иҷрои сарборихои ҷисмонӣ медиҳанд.

Доруҳои зидди ангиналии дигар. *Никорандил* – фаъолгари ҷуйчаҳои калий. Таинот дорад ҳангоми стенокардия, набудани самара аз қабули муҳосирагарҳои ҷуйчаҳои калтсий дар якҷоягӣ бо β -адреномуҳосирагарҳо ва нитратҳои даҳонӣ, ҳангоми норасоии музмини дил. Вояи оғозӣ – 10 мг 2 маротиба дар як рӯз даҳонӣ (сахару беғох) новобаста аз қабули хӯрок. Ҳангоми зарурат вояи дору то 30 мг 3 маротиба дар як рӯз зиёд карда мешавад.

Ивабрадин – интиҳобан ҷуйчаҳои If-и гиреҳи синусиро фурӯ (пахн месозад) менишонад. Самараҳои зиддиангинали ва зиддишемикияш бо пасткунонии вояии ШТД алоқаманд буда, ба ФШ ва муқовимати умумии мавзеи рағҳо умуман таъсир намерасонад. Ба мубодилаи чарбҳо ва карбогидратҳо таъсири манфӣ намерасонад. Вояи оғозии тавсияшаванда 5мг 2 маротибаваро дар як рӯз ташкил медиҳад. Ҳангоми зарурат пас аз 3-4 ҳафта вояи шабонарӯзии дору то 7,5 мг 2 маротиба дар як рӯз зиёд карда мешавад.

Триметазидин – дору таъсири мубодилавӣ дошта, самараи мушакими ситопротективӣ ва зиддишемии дақиқро дорад. Триметазидин аз ҷониби ЦКА барои табобати стенокардия тавсия дода шудааст. Табобати курсӣ (1-3 моҳ) 20 мг 3 маротиба дар як рӯз тавсия дода мешавад.

Идоракунии дислипидемия. Ҳангоми пастсозии сатҳи холестерини хун саҳеҳан басомади сактаи миокард ва фавт паст мегардад.

Барои баҳодиҳии ҳолати мубодилаи Хс спектри липидҳои хун (ХсУ, ТГ, ЛПЗП ва ғ.) муайян карда мешаванд. Нишондодҳо муносиб шуморида мешаванд, агар сатҳи Хс ЛПЗП аз <200 мг/дл (<2,5 ммол/л) ва сатҳи ХсУ аз <192 мг/дл (<5,0 ммол/л) бошанд. Барои паст намудани сатҳи Хс парҳез фармуда мешавад ва дар сурати самара надодани перҳез, мавод-

ҳои липидпасткунанда таин карда мешаванд. Доруҳои асосии липидпасткунанда, дар қатори маводҳои дигар, статинҳо мебошанд (ҷадвали 5).

Ҷадвали 5. Намояндаҳои асосии статинҳо (ингибиторҳои 3-ГМТ-КОА редуктаза).

Моддаи таъсиррасон	Дору	Вояе, ки ҳангоми стенокардия таин карда мешавад
Симвастатин	Зокор, Вазилип, Зорстат, Акталипид, Симвастол, Симгал, Симвалимит, Симвагексал	10-40 мг ш/рӯз
Ловастатин	Мевакор, Холетар, Ровакор, Ловастерол, Кардиостатин	10-40 мг ш/рӯз
Аторвастатин	Липримар, Липтонорм, Аторис, Атомакс, Торвакард, Тулип	10-80 мг ш/рӯз
Розувастатин	Крестор, Росин, Розз, Ровирол	10-40 мг ш/рӯз
Флувастатин	Лескол, Лескол XL	20-80 мг ш/рӯз
Правастатин	Липостат	10-40 мг ш/рӯз

Табобати зидди тромбоситарӣ – ба пешгирии хуруҷҳои стенокардияи устувор, пайдоиши стенокардияи ноустувор, сар задани сактаи шадиди миокард равона гаштаанд; пайдошавии суддаи танаидеворино барҳам дода, бутунин ҷилди лавҳаи атеросклерозиро нигоҳ медоранд.

Дар ҳозира вақт дар амалияи клиникӣ таиноти аз ҳама бисёрро чунин доруҳо, ба мисли: аспирин (туршаки асетилсалитсил); клопидогрел; тиклопидин (тиклид); курантил (дипиридамоил) доранд.

Туршаки (кислотаи) асетилсалитсил. Ба беморони дорои БИД қабули вояи на зиёда аз 75-160мг дору дар як шабонарӯз тавсия дода мешавад.

Тиклопидин дар амалия чарроҳии дил бо курсҳои кӯтоҳмуддат (1-2 моҳ) ҳамчун маводи зидди тромбоситарӣ, пас аз чарроҳии шунтузори шоҳраг-коронарӣ ва ё ангиопластикаи тавассутипусти чархӣ таин карда мешавад. Доруҳо бо вояи 500мг ш/рӯз дар 2 қабул (сахару бегоҳ) таин менамоянд.

Клопидогрел. Клопидогрелро бо вояи 75мг ш/рӯз як маротиба таин менамоянд.

Тикагрелор. ЦКА тавсияи қабули тикагрелорро (дар вояи сарбории 180мг дар як қабул ва доштаистодай – 90мг 2 маротиба дар як ш/рӯз) ба

тамоми беморони дорон алоими коронарии шадид, новобаста аз банақшагирии дурнамои табобат (инвазивӣ ва ё доругӣ) медиҳад.

Курантил. Самараи табобатии курантил бо самараи аспирин монанд мебошад, вале шумораи оризаҳои хунравӣ пас аз қабули курантил бениҳоят каманд. Самараҳои номатлуб аз қабули дору бениҳоят кам мушоҳида мешаванд, асосан пас аз қабули вояҳои баланди $\bar{y} > 200\text{мг}$ дар як шабонарӯз.

β-адреномуҳосирагарҳо талаботи миокардро ба оксиген кам намуда, хавфи пайдоиши ишемияи миокардро ҳангоми сарбориҳои ҷисмонӣ паст месозанд. Мебояд вояи кифояи β-муҳосирагарҳоро ба таври бояду шояд, бо дарназардошти ҳосияти фармаколоҷии онҳо (интиҳобият, фаъолнокии дохили симпатомиметикӣ, липофилӣ) интиҳоб намуд. Ҳангоми интиҳоби дору барои табобати дурударози беморони дорон БИД бояд ҳолати имтиҳонии системаи дилу рағҳо, майли бемориро ба дилзании синусӣ ва ё сустзарбонӣ (брадикардия), мавҷудияти бемориҳои ҳамрадиф (ФБШ, норасоии музмини дил, ДҚ, афзунии липидҳои хун) ба назар гирифт.

Мебояд ба таини β1-муҳосирагарҳои интиҳобӣ (метопролол, бисопролол, атенолол) ҳаракат намуд, чунки доруҳои ғайриинтиҳобӣ метавонанд реаксияҳои рагтангкунандаро аз ҷониби шараёнҳои коронарӣ ва рағҳои мавзей зиёдтар кунанд, ба тангшавии бронхҳо дар беморони дорон бемориҳои обструктивӣ сабаб шаванд.

β-адреномуҳосирагарҳое, ки ҳосияти рагвасеъкунандаро доранд (лабетолол, карведилол) барои беморони дорон БИД бо ФБШ ва/ва ё норасоии музмини дил ва ба беморони дорон нишонаҳои атеросклерози мавзей ҳамчун ҳамрадифи БИД, нишондод доранд. Танҳо интиҳоби вояҳои муносиби доруҳои ин гурӯҳ самараи дақиқи зидди ишемикиро дода, ба пешгӯии беморӣ таъсири мусбиро мерасонад. Маҳакҳои объективии фоиданокии β-муҳосирагарҳо натиҷаи тестҳо бо сарборӣ мебошанд. Дар амалияи клиникӣ поёнравии ШТД-ро дар оромӣ метавон ҳамчун асос барои тест қабул намуд. Дар заминаи қабули β-муҳосирагарҳо дар оромӣ ШТД бояд на зиёда аз 55-60 зарбаро ташкил диҳад. Аммо, чунин пастсозии ШТД на ҳама вақт самараи зидди ишемикии β-муҳосирагарҳоро кафолат медиҳад.

Муҳосирагарҳои ҷуйчаҳои калтсий ба кам намудани теъдоди хуруҷҳои стенокардия, устуворсозии сатҳи ФШ, беҳсозии сифати ҳаёти беморон ёрӣ мерасонанд.

Самараи зидди ангинали аз ин доруҳо, нисбат ба гурӯҳи дигидропиридинҳо аз ҳама беш дар верапамил ва дилтиазем зоҳир мешавад.

Нишондоди таини муҳосирагарҳои ҷуйчаҳои оҳистаи калтсий дар табобати беморони дорои БИД-и музмин ба ҳисоб меравад: якҷоягии стенокардияи шиддат бо брадикардияи синусӣ, алоимии сустии гиреҳи синусӣ, муҳосираи дахлез-меъдачагии дараҷаи I, падидаҳои миёнаи норасоии дил (дигидропиридинҳои дарозтаъсир); якҷоягии стенокардияи шиддат ва ФБШ; стенокардияи вазоспастикии Принсметал; якҷоягии стенокардияи шиддат бо бемориҳои обструктивии шӯшҳо; якҷоягии стенокардияи шиддат бо атеросклерози бо моненаи рағҳои пой; якҷоягии стенокардияи шиддат бо ихтилолҳои мубодилавӣ (метаболикӣ) (афзунии липидҳо дар хун, ДҚ).

Шаклҳои кӯтоҳтаъсири нифедипин дар воҷи беш аз 40мг дар як шабонарӯз ба беморони дорои стенокардияи шиддати устувор тавсия дода намешаванд. Дар клиника, дар замони ҳозира, танҳо дигидропиридинҳои дарозтаъсирро таин менамоянд.

Ингибиторҳои ферменти ангиотензин-табдилдиҳанда (ИФАТ) ба бемороне, ки СМ-ро гузаронидаанд ва нишонаҳои поёнравии вазифаи насосии дилро доранд, нишондод доранд. Дар ин ҳолатҳо ИФАТ ФШ-ро мутадил, пешсарборӣ ва пассарбориро кам, таъсири мустақими номатлуби ангиотензин II ва катехоламинҳоро ба миокард аз байн мебаранд, вазифаи эндотелиро беҳ сохта, тавассути истеҳсоли барзиёди оксиди нитроген лавҳаи атеросклерозиро мустақкам менамоянд. ИФАТ таинот доранд ба бемороне, ки: СМ-ро гузаронидаанду нишонаҳои клиникаи норасоии дилро дошта бошанд; агар фраксияи партоиши меъдачаи чап аз 40% паст бошад; агар СМ девори пеш ба қайд гирифта шуда бошад; инчунин, ба беморони аз 65 сола боло ва бемороне, ки СМ-и калонро гузаронида бошанд (хавфи баланди сар задани СМ-и такрорӣ).

Назорати қанди хун. ДҚ намуди 2 хавфи фавти коронариро дар мардҳо то 2 ва дар занҳо то 4 маротиба афзун мегардонад. Мебояд назорати сатҳи қандро дар беморони дорои стенокардияи устувор барои дар-

ёфти бармаҳали ихтилолҳо дар мубодилаи карбогидратҳо ва назорати дақиқи сатҳи кандӣ хун дар бемороне, ки алақай ДҚ-ро доранд, гузаронид.

Идораи фишорбаландӣ. Дар беморони дорои БИД табобати фишорпасткунанда хавфи оризахоро, баҳусус дар пиронсолон кам менамояд. Нишондоди муносиби пасткунонии ФШ аз сатҳи 140/90 мм сут. сим. паст, ҳангоми мавҷудияти ДҚ ва норасоии гурдаҳо бошад, аз сатҳи 130/85 мм сут. сим. паст мебошад. Ҳангоми интиҳоби доруҳои фишорпасткунанда дар беморони дорои стенокардияи устувор афзалият ба дорухое дода мешавад, ки таъсири хубро ба падидаҳои клиникии БИД мерасонанд: β -адреномуҳосирагарҳо (ҳангоми дилзанӣ, номурааттабии кори дил, СМ дар анамнез), антагонистҳои калтсий (ҳангоми самаран кам ва ё бардошт накардани β -адреномуҳосирагарҳо), ИФАТ (барои пешгирии пайдоиши норасоии дил).

Табобати якҷояи доруҳои зидди ангиналӣ.

Ҳангоми самаран кам аз монотерапия, табобати якҷояи 2-3 доруи зидди ангиналӣ тавсия дода мешавад: муҳосирагари ҷуйчаҳои оҳистаи калтсийи дарозтаъсир аз гурӯҳи нифедепин+ β 1-адреномуҳосирагар; β -адреномуҳосирагар+нитратҳо – баҳусус ба беморони дорои стенокардияи шиддати СВ III-IV; верапамил+нитратҳо – баҳусус ҳангоми мавҷудияти вайроншавиҳои боломеъдачагии назм.

Ҳангоми сар задани устуворшавии беморон ба 2 дору, якҷоягӣ аз се доруро истифода бурдан мумкин аст: β -муҳосирагар+доруҳои изосорбиди динитрат (ё ки изосорбиди мононитрат)+дилтиазем.

Табобати ҷарроҳӣ

Ҳангоми бесамарагии табобати доругӣ, мувофиқи мақсад будани масъалаи ҷарроҳии рағушӯи миокардро баррасӣ менамоянд.

Ангиопластикаи коронарӣ – имкони кушодани шараёнҳои муҳосира ва ё танггаштаре медиҳад. Ангиопластикаи ҷарҳӣ ва стентгузорӣ усули мадохилаи каминвазивӣ бо мақсади табобати рағҳои иллатёфта ҳангоми БИД ба ҳисоб мераванд. Тазриқ дар васеъкунии суроҳии шараёнӣ танггашта бо гузоштани имплант-стент дар ин мавзё асос ёфтааст. Стентгузорӣ бо самаранокӣ даҳҳо маротиба аз ангиопластика бартарӣ дошта, ангиопластика чӣ то стентгузорӣ – бо мақсади тайёр намудани мавзеи иллатбардошта барои стентгузорӣ, ва чӣ пас аз он – бо мақсади зичтар ҳобидани стент ба девори рағ дар ҳолати мавҷудияти хусу-

сиятҳои анатомӣ дар ҷое, ки стент гузошта мешавад, метавонад истифода шавад. Тазриқро бо мақсади ҷӣ пешгирии сакта, ва ҷӣ табобати очилӣ — ғангоми хуручи дил, мегузаронанд. Бо мақсади пешгирии маҳкамшавии стент, ғангоми ҷой доштани нишондод, табиби табобатӣ метавонад табобати доругиро бо таъини сиролимус, эверолимус, зотаролимус ва ғ. гузаронад.

Шунтгузорию шохрағ-коронарӣ — истифодаи рағҳои солимро аз дигар қисматҳои организм бо мақсади «иваз» ва ё ба таври «миёнабур» гузаштани шараёнҳои коронарии танг ва ё маҳкамгашта дар назар дорад. Ба ҳайси шунтҳо варидҳои худӣ беморро истифода мебаранд. Одатан бо ин мақсад вариди зерипусти рон ва ё шараёни даруни синнагиرو истифода мебаранд.

Ивазкунии дили донорӣ — ин тадбири охири дар ҳолатҳои иллати вазнин бардоштани мушакҳои дил, ғангоми бесамар будани дигар усулҳои табобатӣ мебошад.

Дар рафти таҳқиқоти ISCHEMIA исбот гардид, ки табобати ҷарроҳӣ дар оғози табобат хавфи оризаҳои дилу рагии намуди ишемикӣ ва ё фавтро аз сабабҳои гуногун паст намесозад. Маҳз барои ҳамин, пеш аз он, ки ба бемори дорои стенокардия усулҳои инвазивии табобатро таин намоем, бояд, ки ба онҳо ҳамчун қадами аввал, табобати доругии ҳаматарафа боздидшударо тавсия намоем.

Таҳқиқотҳои клиникӣ, аз он ҷумла мушоҳидаҳои «ҳодиса — назорат»-ие, ки дар ҳазорҳо беморон аз ҷониби мо гузаронида шуданд, нишон доданд, ки рағкушоии коронарӣ нисбат ба табобате, ки интиҳоби мантиқан дурусти доруҳоро дар баробари риояи ҷиддии парҳез дарбар мегирад, ягон бартарӣ надорад.

3.4. Пешгирӣ

Пешгирии аввалияи стенокардия ба роҳ надодан ба пайдоиши беморӣ асос ёфта, риояи принципҳои тарзи ҳаёти солимро дарбар мегирад.

Пешгирии дуюмин дар бемороне, ки алақай беморию доранд гузаронида шуда, қабули маводҳои доругиро (нитратҳо, β -муҳосирагарҳо, зидди агрегантҳо, статинҳо, таобати ҷарроҳӣ ва ғ.) дарбар мегирад. Мақсади пешгирии дуюмин пешгирии оризаҳо мебошад.

Пешгирии сеюмини стенокардия дар бемороне, ки алақай оризанок гаштаанд, барои пешгирии фавти бармаҳал гузаронида мешавад ва ҷора-

ҳои барқарорсозиро дар баробари табобати доругию ғайридоругӣ, аз он чумла, ҷарроҳӣ дарбар мегирад.

3.5. Пешгӯии стенокардия

Стенокардия бемории музмини маъҷубкунандаи дил ба ҳисоб меравад. Ҳангоми болоравии стенокардия ҳавфи инкишофи СМ ва ё фавт баланд мегардад. Табобати пайваста ва пешгирии дуҷумин имкони назоратро аз болои равиши стенокардия таъмин намуда, оқибати онро хуб ва қобилияти меҳнатиро ҳангоми маҳдудияти сарборихои ҷисмонӣ ва эҳсоӣ, нигоҳ медоранд.

Риояи дурусти тавсияҳо оид ба табобати стенокардия, қабули нитратҳои дарозтаъсир, статинҳо ва назорати диспансерӣ аз ҷониби кардиолог, имкони расиданро ба ремитсияи дуру дароз медиҳанд.

Тестҳои санҷишӣ

1. Сабаби асосии стенокардия:
 - А. Суддабандӣ.
 - Б. Ангиоспазм.
 - В. Атеросклероз.
 - Г. Ҳама номбаршудагон.
2. Ба омилҳои тағирпазири стенокардия мансубанд ҳама номбаршудагон, ба истисноӣ:
 - А. Камҳаракатӣ.
 - Б. Афзунии холестерин.
 - В. Ирсият.
 - Г. Тамокукашӣ.
3. Дар кадом шакли стенокардия хуручи дардҳо бештар бо механизми спазм ба вучуд меоянд?
 - А. Стенокардияи болорав (прогрессивӣ).
 - Б. Стенокардияи аввалинбор пайдошуда.
 - В. Стенокардияи бармаҳали пас аз сактавӣ.
 - Г. Стенокардияи Принсметал.
4. Чунин самараҳои мусбӣ ба мисли: пастсозии пеш-, ва пассарборӣ, устуворсозии лавҳаи атеросклерозӣ тавассути истеҳсоли оксиди нитроген, бартарафсозии таъсири номатлуби мустақими ангиотензини II, беҳсозии вазифави эндотелий бештар хос мебошанд ба:
 - А. β -адреномуҳосирагарҳо.
 - Б. Антагонистҳои калтсий.
 - В. Нитратҳои дарозтаъсир.
 - Г. ИФАТ.
5. Чиро «Шалолани ишемикӣ» меноманд?
 - А. Дардҳои қафаси синнаро бо нафастангӣ.
 - Б. Пайдарпаии тағиротҳои дар миокард гузарандаро, сар карда аз вайроншавии перфузия то хуручи стенокардия.
 - В. Аз байн бурдани дардҳоро пас аз қабули нитроглитсерин.
 - Г. Агар гипоксияи миокард остонаи зиндамони ӯро гузарад.
6. Ҳангоми муайянсозии шакли тангкунанда (спастикӣ) ҳамчун механизми норасоии коронарӣ, дар сурате, ки ангиографияи коро-

нари тангшавии атеросклерозро наёбад кадом усули ташхисӣ бо-самар ҳисобида мешавад?

А. Тест бо эргометрин.

Б. Эхокардиографияи стрессӣ.

В. Тест бо добутамин.

Г. Велозргометрия.

7. Мониторкунии дурудароз тибқи Холтер дар беморони дорои стенокардия истифода мешавад, барои:

А. Дарёфти ихтилолҳои даргузари назм.

Б. Дарёфти тағиротҳои ишемикӣ.

В. Дарёфти тағирёбии назм.

Г. Ҳама номбаршудагон.

8. Ҳангоми аз байн бурдани хуручи стенокардияи стихиявӣ доруҳои аз ҳама ғоиданок ҳисобида мешаванд:

А. β -адреномуҳосирагарҳо.

Б. Нитратҳо.

В. Антагонистҳои калтсий.

Г. Спазмолитикҳо.

9. Ба басомади стенокардия таъсир мерасонанд ҳама номбаршудагон, ба истисноӣ:

А. Синну сол.

Б. Чинс.

В. Истеъмоли барзиёди намаки ошӣ.

Г. Авзои сиёсӣ.

10. Ишемияи бедарди намуди I-ум ин:

А. Ишемияи бедарди миокард дар бемороне, ки СМ-ро гузаронидаанд.

Б. Ишемияи бедарди миокард бе падидаҳои клиникаи БИД.

В. Ишемияи бедарди миокард, ки дар беморони дорои стенокардия дарёфт гаштааст.

Г. Ҳама номбаршудагон.

11. Дар нақши табобати стенокардия ба натиҷаҳои назаррас аз лиҳози пешгӯӣ расидан мумкин аст:

А. Бо кабули табобати липидпасткунанда дар заминаи риояи принципҳои тарзи ҳаёти солим.

- Б. Бо қабули нитрат, β -муҳосирагар, зидди агрегантҳо.
 - В. Бо қабули зидди оксидантҳо.
 - Г. Бо гузаронидани амалиётҳои рағушӣ.
12. Сабаби стенокардияи Принсметал:
- А. Поёнравии даргузари дастрасии оксиген.
 - Б. Баландшавии талаботи миокард ба оксиген.
 - В. Суддабандӣ.
 - Г. Ҳама номбаршудагон.
13. Ба нишонаҳои хоси стенокардияи Принсметал мансубанд:
- А. Пайдоиши дардҳои саҳт ва бардавом дар як вақти шабонарӯзӣ.
 - Б. Фоидапазирии кам аз нитрат ва β -муҳосирагарҳо.
 - В. Болоравии ST ва тағиротҳои дигари реполяризатсия дар СБД.
 - Г. Ҳама номбаршудагон.
14. Пешгирии дуҷумини стенокардия иборат аст, аз:
- А. Гузаронидани амалиётҳои рағушӣ ҳангоми нишондоди қатъӣ ба онҳо.
 - Б. Қабули тулонӣ ва якумраи доруҳои аҳамияти макониятӣ (патогенетикӣ) дошта.
 - В. Риояи принципҳои тарзи ҳаёти солим.
 - Г. Ҳама номбаршудагон.
15. Бартарияти тредмил-тест нисбат ба велоэргометрия:
- А. Бехатарии таҳқиқот.
 - Б. Доштани хусусияти бештари физиолоҷӣ, иҷрои сарбориҳои баландтар ва тезтар расиданро ба натиҷаҳои дилҳо.
 - В. Нишондоди бештар доштани нафарони носолим ба гузаронидани он.
 - Г. Ҳама номбаршудагон.
16. Истифодаи кадом усули ташҳисӣ барои ташҳисоти стенокардияи микроагӣ мувофиқи мақсад шуморида мешавад?
- А. Томографияи компютерии дил.
 - Б. Коронарография.
 - В. Томографияи позитронӣ эмиссионӣ дил.
 - Г. Велоэргометрия.
17. Ҳамшабеҳи (эквивалентҳои) хуруҷи стенокардия метавонанд бошанд:

А. Нафастангӣ.

Б. Вайроншавии назм.

В. Беҳушшавӣ.

Г. Ҳама номбаршудагон.

18. Ин се омил исботи баланди илмиро (сатҳи далелнокии А) дар пайдоиш ва болоравии БИД доранд?

А. Тамокукашӣ, фарбеҳӣ, истифодаи барзиёди нушокиҳои спирт-дор.

Б. Камхаракатӣ, истифодаи барзиёди намаки ошӣ, диабет.

В. Афзунии холестерин, фарбеҳӣ, омили рӯҳӣ-эҳсосӣ.

Г. Фишорбаландии шараёни, афзунии холестерин, тамокукашӣ.

19. Ин усул стандарти «тиллой» дар ташҳиси стенокардия ба ҳисоб меравад:

А. Велозергометрия.

Б. Ташҳиси липидҳои хун.

В. Эхокардиография.

Г. Коронароангиография.

20. Стенокардия бо монета (обструктивӣ) шуморида мешавад, агар:

А. Рағҳои коронарӣ $>70\%$ танг ва ё муҳосира гашта бошанд.

Б. Рағҳои коронарӣ $>60\%$ танг гашта бошанд.

В. Рағҳои коронарӣ $>90\%$ танг гашта бошанд.

Г. Рағҳои коронарӣ $>50\%$ танг ва ё муҳосира гашта бошанд.

Калиди чавоб ба тестҳо

1	B	2	B	3	Г	4	Г	5	Б
6	A	7	Г	8	B	9	B	10	Б
11	A	12	A	13	Г	14	Г	15	Б
16	B	17	Г	18	Г	19	Г	20	Г

САВОЛНОМА БАРОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ СТЕНОКАРДИЯИ ШИДДАТ

Ҳангоми ҷавоб дар чоркунҷаи мувофиқ аломати «+» гузошта мешавад:

1. Оё дар Шумо дард ва дигар ҳиссиётҳои нофориам дар қафаси синна пайдо мешаванд ё не?
..... Не ☐ Ҳа ☐
Агар «Не», пас:
1а. Оё дар Шумо ҳиссиёти фишор ва ё вазнини дар қафаси синна пайдо мешаванд ё не?
..... Не ☐ Ҳа ☐
Агар «Не» - дар ҳамин савол таваккуф кунед
Агар «Ҳа» - саволи навбатиро диҳед
(агар ба саволҳои навбатии ин қисмат ҷавоб гирифта шавад, ки дар чоркунҷа бо ситораҷа ба қайд гирифта мешавад, пас пурсишро қатъ намоед)
2. Оё ин дард (ҳиссиёти нофориам) ҳангоми ба қуҳ баромадан ва ё ҳаракати саросемавор пайдо мешавад? Не ☐ Ҳа ☐
Ҳеҷ гоҳ тез намеравам ва ба қуҳ намебароям ☐
3. Оё ин дард (ҳиссиёти нофориам) ҳангоми роҳгардӣ бо қадамҳои муқаррарӣ дар ҷои ҳамвор пайдо мешавад? Не ☐ Ҳа ☐
4. Шумо ҷикор мекунед агар дард (ҳиссиёти нофориам) ҳангоми роҳгардӣ пайдо шавад?
Менстам ва ё оҳиста қадам мезанам ☐
Рафтаниро давом медихам, суръатро паст накарда ☐
(агар бемор пас аз қабули нитроглицерин роҳ гаштаниро идома диҳад, қайд кунед)
5. Агар Шумо истед, бо дард (ҳиссиёти нофориам) чи мешавад?
Дард аз байн меравад ☐
Дард аз байн намеравад ☐
6. Чи қадар зуд?
Дар давоми 10 дақиқа ва ё тезтар аз он ☐
Дар давоми беш аз 10 дақиқа ☐
7. Шумо метавонед нишон диҳед, ки дар қучо дардро ҳис мекунед?
а) синна (сеяки боло ва ё миёна) Не ☐ Ҳа ☐
б) синна (сеяки поён) Не ☐ Ҳа ☐
в) қисми чапи қафаси синна аз пеш Не ☐ Ҳа ☐
г) дасти чап Не ☐ Ҳа ☐
д) дигар қисматҳо Не ☐ Ҳа ☐
8. Оё Шумо ин дардро (ҳиссиёти нофориамро) дар ягон ҷои дигар ҳис мекунед? ..Не ☐ Ҳа ☐
Агар «Ҳа», тамоми маълумотҳои иловагиро сабт кунед
9. Оё Шумо оиди ин дард (ҳиссиёти нофориам) ба табиб муроҷиат кардаед? Не ☐ Ҳа ☐
Агар «Ҳа», пас:
Табиб чӣ таъхирот гузошт?
Стенокардия ☐
Дигар беморӣ ☐
10. Ин дард бори аввал қай пайдо шуд ҳафтаи гузашта
11. Чи қадар тез дар давоми моҳи охир ӯ пайдо мешавад маротиба дар ҳафта
12. Оё дар давом як моҳи охир хусусияти дард тағйир ёфтааст? Не ☐ Ҳа ☐
Агар «Ҳа», пас ин тағйиротҳо дар чи зоҳир меёбанд?

(таъсиф қардан)

1. Вайсман Д.Ш. Руководство по использованию Международной классификации болезней в практике врача: в 2-х томах. 2-е изд. Москва, ФБГУ «ЦНИИОИЗ», 2022. Том 1-2. 514с.
2. Кардиология. Национальное руководство. Под общей редакцией Ю.Н. Беленкова и Р.Г. Оганова. Москва ГЭОТАР-Медиа, 2007. С. 147-180.
3. Кардиология. Национальное руководство. Краткое издание / под. ред. Е.В. Шляхто. – 2-е изд., перев. и дополь. – Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. С. 408-423.
4. Козлов К.Л., Шанин В.Ю. Ишемическая болезнь сердца. Клиническая фармакотерапия, хирургическое лечение. СПб, Наука, 2002. С. 5-332.
5. Котова Е.Г., Кобякова О.С., Стародубова В.И. и др. Заболеваемость всего населения России в 2022 году: статистические материалы. М.: ФБГУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2023.
6. Нозиров Ч.Х., Рахимов З.Я., Нарзуллоева А.Р. Школа здоровья. Дастури таълимӣ-услубӣ. Душанбе, 2016. С. 14-80.
7. Нозиров Ч.Х. Ишемическая болезнь сердца и факторы её риска в Таджикистане. Монография. Душанбе, 2020. С. 8-14.
8. Оганов Р.Г., Беленков Ю.Н., Мамедов М.Н. Кардиология: практические аспекты (второе издание). Москва, 2019. С. 86-95.
9. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. Под общей редакцией Чазова Е.Н., Беленкова Ю.Н. М.: Литература, 2005. – 42с.
10. Солимии аҳоли ва ғаёлияти муассисаҳои тандурустӣ дар соли 2023. Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббӣ». Душанбе, 2024. С. 72.
11. Alexander R.P. et al. Interact J Med Res. 2016; 5(2): e12.
12. Ambrosio G et al. 2019; 70(5). P. 397-406.
13. Balla C., Pavasin R., Ferrari R. Cardiology 2018; 140. P. 52-67.
14. Hamm C.W., Braunwald E.B. A clfssofocation of unstable angina revi-sited. Circulation, 2000; 102(1): 118-22.
15. IQVIA, Analytucs/Link/ Mup, 75 стран-MAT Q3 – 2023.
16. Jespersen L. et al. N. Engl J Med. 2015; 372. P. 1291-1300.
17. Knuuti J. et al. Eur Heart J. 2020; 41(3). P. 407-477.
18. Maddox T.M., Reid K.J., Spertus J.A. et al.: Angina at 1 year after myocardial infarction: prevalence and associated findiangs. Arch Intem Med 2008; 168. P. 1310-1316.
19. Moran J et al. N. Engl J Med. 2020; 382. P. 1395-1140.
20. Mozaffarian D et al. Circuition. 2016; 33(4): e380e. P. 360.
21. Ohman E.M. N Eugl J Med. 2016; 374. P. 1167-1176.
22. Padala S.K. et al. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 1074248417698224. 2017 Jan 01.
23. Vos T et al. Lancet. 2012; 380(9859). P. 2163-2196.
24. Wastermann D. J Clin Exp Cardiol. DOI: 10. 4172/2155-9880. 1000387.

Ба ҷопаш 15.05.2025с. ба имзо расид.
Андоза 60х84 1/16.
Адади нашр 100 нусха.
Дар матбааи "Истиклол-2019" ҷоп шудааст.
734036, ш. Душанбе, к. Н. Қарабоғов 60.
Тел.: (+992 37) 234-78-78. E-mail: istiklol_2019@bk.ru



002268071

Китобхонаи миллии Тоҷикистон